



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Obstetricia

Estilos de vida en usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024

TESIS

Para optar por el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia

AUTORA:

Mariana Alessandra ARREDONDO ARAMBURU

ASESORA:

Dra. Emma Felicia SALAZAR SALVATIERRA

Lima, Perú

2025

Agradecimiento

Agradezco a Dios y a la Virgen María, por cuidarme, guiarme y permitirme llegar a este momento.

A mi familia por su constante apoyo y comprensión durante mi formación académica y profesional.

A mi asesora por compartir sus conocimientos, brindar su tiempo y paciencia durante el desarrollo de esta investigación.

A las profesionales obstetras e internas de obstetricia del Centro de Salud Materno Infantil Surquillo por su apoyo con las participantes y consejo.

Dedicatoria

A mis padres, mi hermano Luciano, abuelos y toda mi familia que me han acompañado durante toda esta etapa de formación académica siendo mi soporte cuando los necesité y motivándome durante la carrera.

Índice

Agradecimiento	ii
Dedicatoria	iii
Índice	iv
Índice de tablas.....	v
Resumen	vi
Abstract	vii
I. INTRODUCCIÓN.....	1
I.1. Planteamiento del problema.....	1
I.2. Objetivos	4
I.3. Importancia y alcance de la investigación.....	4
I.4. Limitaciones de la investigación	5
II. MARCO TEÓRICO	6
II. 1. Antecedentes	6
II.2. Bases teóricas.....	9
II. 3. Definición de términos:	21
III. HIPÓTESIS Y VARIABLES.....	23
III.1. Hipótesis	23
III.3. Operacionalización de variables.....	24
IV. MATERIALES Y MÉTODOS.....	26
IV. 1. Tipo de estudio	26
IV.2. Diseño de estudio	26
IV.3. Población	26
IV.4. Muestra.....	27
IV.5. Técnica	27
IV.6. Instrumento de recolección de datos.....	28
IV.7. Procedimientos	29
IV.8. Análisis de datos.....	29
IV.9. Consideraciones éticas	30
V. RESULTADOS	31
VI. DISCUSIÓN	41
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	45
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:.....	48
ANEXOS.....	57

Índice de tablas

Tabla N° 1: Características sociodemográficas de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024.....	31
Tabla N° 2: Datos reproductivos de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024	32
Tabla N° 3: Características del uso de métodos anticonceptivos hormonales de las usuarias con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024	33
Tabla N° 4: Usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024.....	34
Tabla N° 5: Medidas antropométricas de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024	34
Tabla N° 6: Variación de índice de masa corporal (IMC) de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024	35
Tabla N° 7: Incremento de peso de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024.....	35
Tabla N° 8: Incremento de peso según índice de masa corporal (IMC) de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024.....	36
Tabla N° 9: Incremento de peso según método anticonceptivo utilizado de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024.....	37
Tabla N° 10: Tipo de alimentación de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024	38
Tabla n° 11: Frecuencia de consumo de alimentos de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024.....	38
Tabla N° 12: Nivel de actividad física de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024	39
Tabla N ° 13: Tipo de actividad física realizada por semana de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024	39

Resumen

Objetivo: Determinar los estilos de vida en las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024.

Materiales y Métodos: Estudio observacional, descriptivo y transversal. La población estuvo conformada por 43 usuarias de anticonceptivos hormonales con incremento atendidas en octubre y noviembre de 2024. Se aplicaron 2 instrumentos: el “Cuestionario de Índice de alimentación saludable” y la versión corta en español del “Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ)”.

Resultados: Los resultados indican que el 95,35% de las usuarias necesita mejorar su alimentación. El 48,84% tiene un nivel de actividad física moderado y el 32,56% un nivel bajo. Se observa un alto consumo de dulces y gaseosas (60,47%) y embutidos (62,79%). Además, el 67,44% no realiza actividades físicas vigorosas y el 76,74% no realiza actividades moderadas, con un 80% dedicando más de 2 horas a actividades sedentarias. El 62,79% ganó entre 5 y 10 kg. Al inicio del uso de anticonceptivos hormonales, el 44,2% tenía un IMC normal, el 32,6% sobrepeso, el 20,9% obesidad tipo I y el 2,33% obesidad tipo II. Posteriormente, estas proporciones cambiaron a 13,95% con peso normal, 39,5% con sobrepeso, 30,2% con obesidad tipo I y 16,3% con obesidad tipo II.

Conclusión: Se concluye que las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso presentan un estilo de vida que necesita realizar mejoras para llegar a un nivel saludable.

Palabras clave: Estilos de vida, Anticoncepción Hormonal, Incremento de peso, Centro Materno Infantil.

Abstract

Objective: To determine the lifestyles of users of hormonal contraceptive methods who have experienced weight gain at the Centro Materno Infantil Surquillo, 2024.

Materials and Methods: Observational, descriptive, and cross-sectional study. The population consisted of 43 users of hormonal contraceptive methods who experienced weight gain during the months of October and November 2024. Two instruments were applied: the "Healthy Eating Index Questionnaire" and the short Spanish version of the "International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)."

Results: The results indicate that 95.35% of users need to improve their diet. 48.84% have a moderate level of physical activity, while 32.56% have a low level. There is a high consumption of sweets and soft drinks (60.47%) and processed meats (62.79%). Additionally, 67.44% do not engage in vigorous physical activities, and 76.74% do not participate in moderate activities, with 80% spending more than 2 hours on sedentary activities. 62.79% gained between 5 and 10 kg. At the start of using hormonal contraceptives, 44.2% had a normal BMI, 32.6% were overweight, 20.9% had class I obesity, and 2.33% had class II obesity. Subsequently, these proportions changed to 13.95% with normal weight, 39.5% overweight, 30.2% with class I obesity, and 16.3% with class II obesity.

Conclusion: It is concluded that users of hormonal contraceptive methods who have experienced weight gain exhibit a lifestyle that requires improvements to reach a healthy level.

Keywords: Life Style, Hormonal Contraception, Weight Gain, Maternal-Child Health Centers.

I. INTRODUCCIÓN

I.1. Planteamiento del problema

Determinación del problema

Los estilos de vida de la población durante los últimos años se han caracterizado por ser considerados no saludables o riesgosos para la salud debido a su asociación con enfermedades crónicas como el sobrepeso y la obesidad. Estas enfermedades han triplicado sus cifras en los últimos años en la mayoría de regiones en el mundo según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud en 2016 y en 2022 se estimaba que 43% de la población adulta tiene sobrepeso y 16% eran obesos ¹. Asimismo, la situación en Perú es similar, en donde casi un tercio de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad ². Dichas enfermedades tienen una gran relación con los estilos de vida no saludables porque incluyen una gran ingesta calórica y poca o nula actividad física, lo que representa un riesgo para la salud en caso no se adopte un estilo de vida saludable ³.

Según la Encuesta Nacional de Actividad Física y Hábitos de Vida Saludable realizada en el 2021 por el Instituto Peruano del Deporte, la mayoría de mujeres del Perú no realiza actividad física por distintos motivos en los cuales se destaca la falta de tiempo o por realizar otras actividades relacionadas al trabajo y estudio ⁴. Por otro lado, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición junto al Instituto Nacional de Salud informaron por medio del informe de la encuesta Vigilancia Alimentaria Nutricional por Etapas de Vida (VIANEV) de 2017-2018 que la mayoría de la población de adultos de 18 a 59 años consumía más de la cantidad recomendada de carbohidratos, alimentos procesados y ultra procesados ⁵.

La proporción de mujeres que deciden usar un método anticonceptivo también se ha incrementado. La Organización Mundial de la Salud estimó que 842 millones mujeres utilizan métodos anticonceptivos ⁶. A nivel de Latinoamérica, 74% de mujeres utilizan algún método anticonceptivo y de estas 67% utiliza métodos anticonceptivos modernos, los cuales incluyen los anticonceptivos hormonales ⁷.

En Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 2023 realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática a nivel nacional, la mayoría de las mujeres actualmente unidas (77,4%) usaban algún método anticonceptivo. Gran parte de las mujeres utiliza como método anticonceptivo al inyectable, el condón masculino, esterilización femenina, pastilla e implante subdérmico. Sin embargo, muchas mujeres que usan la pastilla anticonceptiva y el inyectable anticonceptiva han dejado de usar dichos métodos por razones relacionadas con el mismo método, por sus efectos secundarios o por razones de salud ⁷.

Las mujeres que utilizan métodos anticonceptivos hormonales pueden verse afectadas por los efectos secundarios de estos métodos que resultan negativos para su salud, entre los cuales destacan la cefalea, el aumento o pérdida de peso, amenorrea, sangrado menstrual irregular prolongado y pérdida del deseo sexual ⁸. Estudios realizados en diferentes establecimientos de salud del Ministerio de Salud (MINSA) del Perú evidenciaron que las mujeres que utilizaron el inyectable mensual, inyectable trimestral, anticonceptivos orales combinados y el implante subdérmico presentaron ganancia y/o pérdida de peso ⁹. La presencia de los mencionados efectos influye sobre la aceptación, adherencia y abandono de los métodos anticonceptivos ^{10,11}. El efecto de que se produzca una ganancia de peso puede afectar a la salud de las mujeres, las cuales podrían tener un mayor riesgo de padecer sobrepeso y obesidad si no siguen un adecuado control.

El uso de métodos anticonceptivos hormonales contribuye al ejercicio de una sexualidad saludable en las mujeres; no obstante, la presencia de

hormonas puede ocasionar aumento de peso, siendo este en algunos de manera excesiva y perjudicial para la salud. Adicionalmente, el incremento de peso asociado al sobrepeso y obesidad puede interferir en la salud sexual y reproductiva de la mujer, así como en su calidad de vida. Investigaciones han reportado que mujeres con sobrepeso pueden presentar disfunciones sexuales como disminución de la libido, insatisfacción sexual, alteraciones del orgasmo, dispareunia y dificultades durante la excitación y lubricación vaginal. Además, se ha encontrado que existe un impacto a nivel psicológico como la depresión, ansiedad, estrés, disminución de la autoestima, inseguridades sobre su imagen corporal, entre otras ^{12,13}. Por otro lado, el sobrepeso y obesidad incrementa el riesgo de que se presenten cánceres como el de endometrio, ovario o mama, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y metabólicas. En adición a ello, también está asociado a las irregularidades menstruales, síndrome de ovario poliquístico, problemas con la implantación e infertilidad ¹⁴.

El estilo de vida que adopte la usuaria de estos métodos hormonales podría favorecer o disminuir el riesgo de presentar el efecto sobre la ganancia de peso, destacando el estilo de vida en relación a la alimentación y la realización de actividad física. La presente investigación busca describir los estilos de vida que tienen las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales y que han presentado un incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo.

Formulación del problema

Problema general

¿Cómo son los estilos de vida en las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo?

I.2. Objetivos

Determinar los estilos de vida en las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024.

Objetivos específicos:

- Identificar a las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales que han experimentado un incremento de peso, a partir de los tres meses de uso.
- Clasificar a las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso según el índice de masa corporal, a partir de los 3 meses de uso.
- Describir los estilos de vida sobre la alimentación en las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso.
- Caracterizar los estilos de vida sobre la actividad física en las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso.

I.3. Importancia y alcance de la investigación

Los estilos de vida no saludables son un problema presente en Perú y el mundo, los cuales contribuyen a problemas de salud como el sobrepeso y la obesidad. En adición a ello, el uso de métodos anticonceptivos hormonales puede predisponer a la aparición de efectos secundarios como el aumento de peso el cual acompañado a un estilo de vida no saludable puede resultar perjudicial para la salud de las mujeres que los utilizan. Es por ello, que existe la necesidad de indagar dicho problema con el fin de contribuir al manejo de esta problemática.

Los resultados serían de utilidad para la comunidad científica dedicada a la salud sexual y reproductiva debido a que aportaría al conocimiento sobre el incremento de peso como efecto secundario al uso de métodos anticonceptivos hormonales. Asimismo, profesionales de salud dedicados al estudio de la nutrición, actividad física y medicina en general también

podrían beneficiarse de la información obtenida porque brinda conocimientos de los estilos de vida que adopta un grupo poblacional como son las mujeres en edad reproductiva.

Por otro lado, en caso se encuentre que las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso presentaron estilos de vida no saludables, ello podría servir de antecedente para la elaboración de programas, estrategias u otras intervenciones destinadas a la promoción y fortalecimiento de los estilos de vida saludables por parte de las autoridades locales de salud.

I.4. Limitaciones de la investigación

El estudio no presenta una muestra representativa de la población de usuarias de métodos anticonceptivos hormonales al ser un muestreo no probabilístico, por lo cual sus resultados no pueden ser generalizables a otros grupos de usuarias. Sin embargo, puede ser inicio de otros trabajos de investigación que den conclusiones extrapolables.

Además, existe la posibilidad de que las participantes no hayan respondido con sinceridad a algunas preguntas por vergüenza o para aparentar un estilo de vida más saludable al que en realidad presentan, existiendo así un sesgo de información.

II. MARCO TEÓRICO

II. 1. Antecedentes

Serrano Casilla L. realizó un estudio en el año 2023 con el objetivo de determinar la relación del tiempo de uso de métodos hormonales de progestágenos con el incremento de peso en usuarias de un centro de salud en Tacna. La metodología de la investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo, correlacional, retrospectivo y de corte transversal. Los resultados arrojaron que la mayor frecuencia de tiempo de uso de alguno de estos métodos fue de 1 a 3 años (47,6 %), y que la mayor parte aumentó de 7 kg a más (28 %). El estudio concluye que existe relación entre el tiempo de uso de los métodos hormonales de progestágeno y el incremento de peso en las usuarias ¹⁵.

Orbe Orozco S. publicó un estudio en el año 2021 en Chile, el cual tuvo como objetivo relacionar el perfil de la usuaria de anticonceptivos hormonales en universitarias millennials, los estilos de vida y los niveles de estrés académico. El tipo de estudio fue cuantitativo, de diseño analítico transversal. Los resultados arrojaron que la mayoría refiere tener una alimentación balanceada, pero que más de la mitad de las estudiantes consume muchos alimentos “chatarra”; además, el 76 % tiene un exceso de peso de 4 kg. Por otro lado, 35,5 % no realizaba ninguna actividad física. La autora determinó que la relación entre las variables fue estadísticamente significativa. La investigación concluye que las mujeres que tienen una mayor adherencia a los métodos anticonceptivos realizan más actividad física y tienen una alimentación balanceada ¹⁶.

Flores Ormeño M. y Rojas Vera M. realizaron una tesis en Chíncha (Perú) con el fin de determinar si existía relación entre los anticonceptivos hormonales y la obesidad en usuarias continuadoras del centro de salud Mala en Cañete. La investigación fue de tipo descriptivo y de corte transversal. Los resultados señalan que, al inicio del uso de los anticonceptivos hormonales, el 37,1 % de las usuarias tenía un IMC

normal y el 62,9 % se encontraba en sobrepeso. Al momento de la recolección, el 40,8 % tenía obesidad tipo II, el 34,3 % obesidad tipo I y el 24,9 % sobrepeso. La prueba de Chi cuadrado indicó un valor de 29,003, por lo que rechazaron su hipótesis nula. Por último, concluyeron que los anticonceptivos hormonales están relacionados con la obesidad ¹⁷.

Silva Delgado S. publicó en 2021 una tesis realizada en Perú, cuyo objetivo fue determinar el uso de anticonceptivos hormonales como factor asociado a la obesidad en mujeres en el periodo de edad fértil. La autora usó la base de datos de la encuesta ENDES 2018 para obtener información sobre la obesidad y el uso de anticonceptivos hormonales en mujeres en edad fértil. Sus resultados indicaron que las mujeres que usaron el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) presentaron 1,38 veces más riesgo de padecer obesidad. Por otro lado, el estudio determinó que no existía relación entre la obesidad y el uso de los anticonceptivos orales combinados, inyectables, implante subdérmico y parche hormonal. Silva concluyó que, de todos los anticonceptivos hormonales estudiados, solo el anticonceptivo oral de emergencia mostró asociación significativa con la obesidad ¹⁸.

Díaz Chavez V. y Hernández Cañeda R. realizaron una tesis en 2021 en Ica con el fin de determinar la relación entre el uso de anticonceptivos hormonales y el peso en usuarias de planificación familiar de un hospital. Las investigadoras realizaron un estudio transversal, analítico y correlacional, donde hicieron uso de la información consignada en las historias clínicas y aplicaron la prueba t de Student para el análisis de su hipótesis. Los resultados arrojaron que el 81,87 % de las mujeres que utilizaron anticonceptivos hormonales presentaron un IMC previo de sobrepeso y obesidad. Además, encontraron que el uso de métodos hormonales y el tiempo de uso tuvieron una relación significativa con el aumento de peso en comparación al peso previo al uso del método hormonal (t igual a -9,212 y un p-valor de 0,000). El estudio concluyó que el uso de métodos hormonales presentó una relación significativa con el aumento de peso en usuarias de planificación familiar ¹⁹.

Ustua Sanchez T. publicó un estudio en Abancay (Perú) en el año 2021, que tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso del acetato de medroxiprogesterona (AMDP) y la variación del Índice de Masa Corporal (IMC) en usuarias de planificación familiar del Centro de Salud Pueblo Joven Centenario durante el año 2019. El tipo de estudio fue observacional, con enfoque cuantitativo y diseño correlacional. Los resultados de la investigación arrojaron que existe una correlación moderada entre el uso del acetato de medroxiprogesterona y la variación del IMC; una correlación baja entre el IMC al inicio y el uso del AMDP; y una correlación moderada en el incremento de peso por trimestres desde el uso del AMDP. La autora concluye que sí existe relación entre el uso del acetato de medroxiprogesterona y la variación del Índice de Masa Corporal ²⁰.

Morales Laurente N. publicó en 2019 una tesis realizada en Huancavelica (Perú), con el objetivo de determinar el perfil de forma de vida en usuarias de planificación familiar con IMC elevado. El estudio fue de tipo cuantitativo, observacional, descriptivo y de corte transversal. Los resultados mostraron que la mayoría de las mujeres presentaron hábitos de nutrición deficientes (65,6 %) y prácticas de ejercicio físico deficientes (60,7 %), entre otras dimensiones del estilo de vida. La autora concluyó que la forma de vida de las usuarias de planificación familiar presenta una deficiente nutrición y ejercicio físico, mientras que evidenciaron suficientes prácticas en salud en otras dimensiones del estilo de vida, como soporte interpersonal, actualización, manejo de estrés y responsabilidad en salud ²¹.

Velasquez Capristan M. publicó una tesis en Lima durante 2019 con el objetivo de determinar el aumento del índice de masa corporal (IMC) en usuarias del acetato de medroxiprogesterona (AMDP) en el Centro de Salud Márquez. La metodología aplicada para el mencionado estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, retrospectivo y de corte

transversal. La autora encontró que hubo una disminución en la proporción de usuarias con IMC normal, que pasó de 53,8 % a 47,7 %, mientras que la proporción de sobrepeso aumentó de 35,4 % a 38,5 % y la proporción de obesidad incrementó de 9,2 % a 12,3 %. La investigación concluyó que existe un aumento del índice de masa corporal en usuarias del acetato de medroxiprogesterona al año de uso ²².

II.2. Bases teóricas

Estilo de vida

El estilo de vida, según la Organización Mundial de la Salud, se entiende como “una forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados por factores socioculturales y características personales” ²³. Asimismo, en consenso con otros autores se puede definir al estilo de vida como los patrones conductuales o hábitos que guardan una estrecha relación con la salud. Este concepto también hace referencia a las actividades, hábitos o rutinas diarias de un individuo como las características de alimentación, sueño, consumo de alcohol, cigarro y drogas, actividad física entre otras ^{24–26}.

Los estilos de vida saludables son aquellos que permiten el disfrute de una buena salud y calidad de vida donde se reduce el riesgo de padecer enfermedades. Asimismo, busca una armonía y equilibrio en su dieta, actividad física, vida sexual, manejo del estrés, capacidad intelectual, recreación, descanso, higiene, paz y relaciones interpersonales ²⁷.

Desarrollo de los estilos de vida

Icek Ajzen desarrolló en 1991 la teoría del comportamiento planificado (TCP), la cual busca explicar cómo las personas toman decisiones sobre su comportamiento. Este modelo postula que los comportamientos o conductas de las personas surgen de la intención que tienen para realizarlos. Esta teoría cuenta con tres componentes: actitud, normas

subjetivas y control del comportamiento percibido. El primer componente es la actitud positiva o negativa que la persona tiene acerca de un comportamiento. El segundo hace referencia las percepciones que la sociedad, círculo familiar y social tiene sobre los comportamientos. Por último, el tercer componente de control conductual hace referencia a la percepción que tiene el individuo sobre su propia capacidad para realizar el comportamiento. Esta teoría supone que estos componentes actúan como factores que motivan la intención de las personas para realizar un determinado comportamiento o cambio de conducta, ya que indican qué tanta disposición tienen para esforzarse en llevar a cabo dicha conducta. Asimismo, se explica que, mientras mayor sea la participación de un individuo en una conducta, es más probable que la realice. Cabe mencionar que también pueden influir factores no relacionados con la motivación, como las oportunidades disponibles y los recursos, tales como el tiempo, el dinero y las habilidades. Por ende, si una persona tiene la intención de adoptar un estilo de vida y cuenta con las oportunidades y los recursos necesarios, este cambio tendría mayores probabilidades de cumplirse ²⁸⁻³¹.

James Prochaska y Carlo DiClemente desarrollaron el Modelo Transteórico del Cambio para explicar cómo las personas modifican sus comportamientos relacionados con la salud. Este modelo se caracteriza por describir el cambio de comportamiento como un proceso gradual que se lleva a cabo en seis etapas. La primera etapa es la precontemplación, en la cual la persona no tiene la intención de cambiar su conducta, ya sea porque no es consciente de tener un problema o por falta de motivación. La segunda etapa es la contemplación, en la que se reconoce la existencia de un problema y se comienza a pensar en corregirlo, aunque aún no hay un compromiso firme para lograrlo. La tercera etapa es la preparación, donde se manifiesta la intención de cambiar y se elabora un plan de acción, aunque todavía no se ha comenzado a implementar o se realizan solo pequeños cambios. La cuarta etapa es la acción, momento en el que la persona efectúa modificaciones en su comportamiento. La quinta etapa es el mantenimiento, en la que se consolidan los cambios y

se busca evitar recaídas. Por último, puede ocurrir una recaída, que representa la sexta etapa, en la que la persona retoma las conductas que tenía anteriormente ³².

Otro modelo que puede explicar la adopción de un estilo de vida es el modelo de Nola Pender, propuesto en 1990, revisado y actualizado años posteriores hasta 2018. La autora propuso el Modelo de Promoción de la Salud (MPS) a fin de explicar cómo las personas adoptan decisiones sobre el cuidado de su propia salud. Este modelo permite comprender el comportamiento de los usuarios de salud y así generar estilos de vida saludables mediante intervenciones ³³. El modelo sigue un enfoque biopsicosocial que señala que las características y experiencias individuales, conocimientos, cogniciones y afectos específicos influyen en el comportamiento de salud ³⁴.

El modelo explica que existen tres componentes que pueden motivar a adquirir comportamientos con respecto a la salud. El primer componente son las características y experiencias personales que abarca sus conductas previas, factores biológicos, psicológicos y socioculturales que tenga un individuo. El segundo componente incluye a las cogniciones y afectos de la persona. Este abarca a los beneficios que el individuo percibe sobre alguna conducta, las barreras que creen que impiden realizar la conducta, la autoeficacia, el afecto que tenga con la actividad a realizar, y las influencias interpersonales. Adicionalmente, es en este componente donde se puede realizar la promoción de salud por medio del compromiso con un plan de acción, demandas que requiere ello y las preferencias. Por último, el tercer componente es el resultado conductual que se refiere al logro de un comportamiento saludable ^{33,35}.

En adición a lo mencionado, Nola Pender explica que el estilo de vida está relacionado a 6 dimensiones ³⁴:

1. Alimentación o nutrición: patrones de alimentación y selección de alimentos.

2. Ejercicio o actividad física: adhesión a un patrón regular de actividad física.
3. Apoyo interpersonal: mantenimiento de relaciones positivas con otras personas e intimidad.
4. Responsabilidad por la salud: aceptar y tener control del propio bienestar.
5. Manejo del estrés: reconocimiento de las fuentes de estrés y cómo actúa frente a ello.
6. Autoactualización: tener un propósito en la vida y buscar desarrollarse profesionalmente.

Para efectos del presente estudio sólo se va a considerar a la dimensión alimentación y actividad física debido a que estas dimensiones presentan relación con el incremento de peso.

Nutrición y alimentación

La nutrición y alimentación tienen una importancia en la salud de las personas debido a que están relacionadas con el desarrollo de enfermedades crónicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que una alimentación saludable ayuda a prevenir la malnutrición y enfermedades no transmisibles. La OMS informa que existen 5 factores de riesgo para adquirir enfermedades no transmisibles que están relacionados con la alimentación y ejercicio: hipercolesterolemia, obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial y consumo insuficiente de frutas y verduras ³⁶.

La nutrición tiene un concepto amplio que ha evolucionado a través de los años. Uno de sus conceptos actuales es el propuesto en la Declaración de Giessen, en donde se define como la “constitución de otros alimentos y de las interacciones con los sistemas biológicos, sociales y ambientales más relevantes”³⁷. Asimismo, la nutrición es necesaria en el organismo porque aporta la energía necesaria para mantener la integridad y el funcionamiento de las estructuras corporales, construye y repara las estructuras corporales, y regular los procesos metabólicos del cuerpo ³⁸.

Debe mencionarse que la nutrición es diferente a la alimentación debido a que el primero hace referencia al proceso interno metabólico mientras que la alimentación es la forma de adquirir los alimentos, no obstante, ambos conceptos están relacionados ³⁹.

La alimentación saludable es aquella que permite satisfacer las necesidades nutricionales para un adecuado crecimiento y desarrollo físico e intelectual ³⁹. Está caracterizada por ser completa, equilibrada, suficiente, adecuada, diversificada e inocua. Adicionalmente, se considera que debe estar complementada con otros hábitos de estilos de vida saludable como evitar sedentarismo, el consumo de cigarrillo, la ingestión de bebidas alcohólicas y otras sustancias tóxicas que afecten la salud ⁴⁰.

La alimentación saludable en la mujer debe proporcionar los suficientes nutrientes esenciales y una mayor cantidad de antioxidantes, fibras, proteínas de origen vegetal, y electrolitos como el potasio, calcio y magnesio para la protección cardiovascular. Además, requiere la presencia de ácidos grasos insaturados y una baja cantidad de ácidos grasos saturados. Esta alimentación no solo permite evitar el sobrepeso y la obesidad, sino también ayuda a prevenir la osteoporosis, sarcopenia y diferentes enfermedades que pueden aparecer en su curso de vida ⁴¹.

Se recomienda que se mantenga una alimentación saludable a lo largo de las diferentes etapas de la vida de la mujer ya que puede ser beneficioso durante los cambios hormonales de los ciclos menstruales, para la lactancia, la salud ósea y la menopausia, permitiendo más adelante un envejecimiento más saludable ⁴¹.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que una alimentación saludable incluye la ingesta de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales ⁴². En sus últimas guías alimentarias

publicadas en el 2023 brinda recomendaciones sobre el consumo de grasas, grasas saturadas, grasas trans y carbohidratos.

En la guía “Saturated fatty acid and trans-fatty acid intake for adults and children” menciona que los adultos y niños deben reducir su ingesta de ácidos grasos saturados al 10% de la ingesta energética total y si es posible sustituirlos por ácidos grasos monoinsaturados de origen vegetal o carbohidratos con fibra dietética natural tales como cereales integrales, verduras, frutas y legumbres ⁴³. El consumo de grasas no saturadas está asociadas a menores riesgos cardiovasculares. Se puede destacar el consumo de ácidos grasos como el omega 3 y 6 por su efecto cardioprotector y ante la resistencia a la insulina. Por otro lado, las grasas trans y saturadas de los alimentos procesados se asocian a un mayor riesgo cardiovascular e impacto negativo en la salud ⁴¹.

La guía “Total fat intake for the prevention of unhealthy weight gain in adults and children” sugiere que los adultos deberían limitar su ingesta total de grasas a un 30% o menos de la ingesta total de energía. Asimismo, la mayoría de grasas consumidas deberían ser ácidos grasos insaturados (presentes en pescados, palta, frutos secos, aceite de girasol y oliva, soja) mientras que los ácidos grasos saturados (como la grasa de la carne, mantequilla, manteca) y los ácidos grasos trans (presentes en “comida chatarra” como pasteles, postres, galletas, aceite de cocina, pizza) no deberían exceder del 10% y 1% de la ingesta total de energía respectivamente ⁴⁴.

Las recomendaciones de la guía “Carbohydrate intake for adults and children: WHO guideline” señalan que los carbohidratos que se deben consumir son los granos integrales, vegetales, frutas y legumbres. En relación a la ingesta de verduras y frutas, la OMS recomienda que sea en una cantidad de al menos 400 gramos por día. Adicionalmente, la ingesta diaria de fibra debe ser de por lo menos 25 gramos por día ⁴⁵. El consumo de carbohidratos es necesario por su gran aporte de energía y se ha

encontrado que el consumo de los granos integrales puede reducir los riesgos de padecer enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Asimismo, la ingesta de frutas y verduras también tiene un efecto a nivel gastrointestinal debido a su alto contenido de fibras, lo que ayuda a controlar mejor la sensación de saciedad y los niveles de colesterol ⁴¹.

La OMS también considera que una dieta sana debe evitar el consumo de más de 5 gramos o una cucharadita de sal al día. En adición a ello, menos del 10% de la ingesta calórica total o menos de 50 gramos debe corresponder a los azúcares libres como los azúcares que son añadidos a las bebidas y alimentos procesados ⁴².

Actividad física

La actividad física es otra de las dimensiones del estilo de vida. Esta es definida por la OMS como cualquier movimiento del cuerpo producido por los músculos esqueléticos y que consume energía. Se considera como actividad física a todo movimiento, incluyendo el desplazamiento y actividades de ocio ⁴⁶.

Se ha demostrado que la actividad física tiene beneficios en la salud debido a que ayuda a la prevención y control de enfermedades no transmisibles como la diabetes mellitus, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer e hipertensión arterial. En adición a ello, la actividad física es beneficiosa para las personas con sobrepeso y obesidad debido a que reducen el riesgo de mortalidad al mismo riesgo que presenta un peso saludable y que también se ejercita ⁴⁶. Por otro lado, también tiene un efecto positivo sobre la salud mental, la calidad de vida y el bienestar.

La realización de actividad física es de crucial importancia en la salud de la mujer sobre todo durante la adultez temprana que es la etapa en donde se pueden adquirir mejor los estilos de vida. No obstante, existen muchas barreras a nivel personal, social, ambiental que impiden que las mujeres

puedan tener una mejor rutina de actividad física. Algunas barreras existentes son el tiempo, las labores y deberes dentro de la familia, el apoyo social, creencias religiosas y culturales, los entornos comunitarios y físicos ⁴⁷.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos entre los 18 y 64 años deben realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 a 300 minutos. La actividad física aeróbica, también conocida como actividades de resistencia, es aquella en donde los músculos se mueven rítmicamente en un período de tiempo como correr, nadar y manejar bicicleta. La intensidad moderada implica que la actividad sea realizada con una intensidad de 3 a 5,9 veces mayor que cuando la persona se encuentra en reposo. Por otro lado, las actividades aeróbicas vigorosas deberían ser realizadas por lo menos entre 75 a 150 minutos a lo largo de la semana. Este tipo de actividades deben realizarse con una intensidad 6 o más veces mayor a la del estado de reposo ^{48,49}.

Planificación Familiar

La planificación familiar puede definirse como el conjunto de actividades, intervenciones, información, medios y métodos que permiten a las personas decidir sobre cuándo tener hijos, cantidad y el intervalo de tiempo entre estos. Adicionalmente, la planificación es un derecho sexual y reproductivo que permite a las personas el goce de una vida sexual y reproductiva saludable y placentera. Asimismo, aporta a disminuir la incidencia de la mortalidad materna ocasionada por complicaciones del embarazo y el parto debido a que se evita embarazos no planificados. El impacto de la planificación familiar se refleja a nivel económico, ambiental y social en los ámbitos familiares y dentro de la comunidad ⁵⁰⁻⁵².

La planificación familiar forma parte de la atención en salud sexual y reproductiva que se brinda en los establecimientos de salud públicos del Perú a nivel nacional. Esta atención está regulada y guiada por la Norma Técnica de Planificación Familiar, aprobada en 2016 y modificada en 2017, siendo esta última revisión la que se mantiene vigente en la

actualidad. La creación de esta norma tuvo como finalidad el contribuir al ejercicio de los derechos de manera responsable, libre e informada en relación a la decisión del número y espaciamiento de los hijos por medio de servicios de planificación familiar de calidad. Esta normatividad ha permitido establecer las disposiciones para los procesos de atención en planificación familiar para garantizar que estos sean de calidad y puedan darse con seguridad. Asimismo, estandariza una clasificación de los métodos anticonceptivos distribuidos en los establecimientos del MINSA a nivel nacional e informa las características de cada método ⁵³.

Más allá de que la planificación familiar sea una estrategia de salud sexual y reproductiva, esta forma parte de la vida de las mujeres, su rutina y hábitos diarios debido a que involucra la participación de las mujeres para su adecuado cumplimiento.

Métodos anticonceptivos

Los métodos anticonceptivos son aquellos procedimientos que previenen o ayudan a que disminuya la posibilidad de que se dé la fecundación en mujeres fértiles, y estos pueden ser usados por ellas como por sus parejas. El uso de métodos anticonceptivos contribuye a que se cumplan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres porque pueden decidir sobre la cantidad de hijos y el momento en que desean tenerlos ⁵⁴.

La decisión de usar o no algún método anticonceptivo puede estar influenciada por factores como el sexo, género, la edad, número de hijos anteriores, nivel socio económico, experiencia previa de efectos secundarios, oposición cultural o religiosa, calidad de los servicios de salud disponibles, opciones limitadas o disponibles, entre otros ^{50,55}.

Se puede clasificar a los métodos anticonceptivos en relación a su reversibilidad, duración, mecanismo de acción. La Norma Técnica de Planificación Familiar vigente en Perú clasifica a los métodos anticonceptivos como: métodos de abstinencia periódica, método de

lactancia materna exclusiva y amenorrea, métodos de barrera, anticonceptivos hormonales, anticoncepción quirúrgica voluntaria y la anticoncepción de emergencia ⁵³.

El primer grupo es de métodos anticonceptivos de abstinencia periódica, los cuales se basan en la identificación de signos de los períodos fértiles y no fértiles de la usuaria. Incluye al método del ritmo, método del moco cervical o de Billings, y método de los días fijos o método del Collar. El método de la lactancia materna exclusiva se basa en la anovulación fisiológica postparto durante la lactancia ocasionado por el aumento de la hormona prolactina. Por otro lado, los métodos de barrera, comúnmente conocidos como preservativos o condones, actúan como una barrera física que impide el pase de los espermatozoides durante la eyaculación hacia el tracto femenino. Por último, la anticoncepción quirúrgica voluntaria es un tipo de método anticonceptivo irreversible por lo que son permanentes y deben realizarse por procedimientos quirúrgicos ^{50,53}.

Métodos anticonceptivos hormonales

Los métodos anticonceptivos hormonales son aquellos métodos cuyo mecanismo de acción tiene como fin el impedir o no producir la ovulación en la mujer mediante la influencia de hormonas sintéticas. Según la cantidad de hormonas que utilizan se pueden dividir en dos subgrupos: los métodos anticonceptivos hormonales combinados y los anticonceptivos de solo progestina. Los anticonceptivos hormonales combinados tienen dentro de sus componentes a las hormonas estrógeno y progestágeno, las cuales inhiben la ovulación y espesan el moco cervical. Dentro de este grupo se encuentran los anticonceptivos orales combinados y los anticonceptivos hormonales combinados de depósito.

Los anticonceptivos orales combinados (AOC) tienen una tasa de falla de uso perfecto de 0.3 embarazos por cada 100 mujeres que lo usan. Se administran de forma oral y vienen en presentaciones de 21 o 28 pastillas, las cuales deben tomarse a diario para mantener su efectividad ⁵³.

Los anticonceptivos hormonales combinados de depósito son conocidos comúnmente como inyectable o ampolla mensual, la cual se debe administrar entre el primer y quinto día del ciclo menstrual. Este método tiene una tasa de falla de uso perfecto de 0.05 embarazos por cada 100 mujeres que lo usan. Este inyectable se administra por vía intramuscular en la región glútea o deltoidea por medio de la técnica en Z. Se puede encontrar con la composición de 5 mg de cipionato de estradiol y 25 mg de acetato de medroxiprogesterona ⁵³.

Por otro lado, los anticonceptivos hormonales de sólo progestina presentan un mecanismo similar a los anticonceptivos hormonales combinados, pero no usan los estrógenos, solo progestágenos. Dentro de los métodos que utilizan esta composición se encuentran los implantes subdérmicos.

El implante de sólo de progestina o subdérmico es una pequeña varilla, cápsula o cilindro que se coloca debajo de la piel de la parte superior interna del brazo. Este método brinda una protección a largo plazo ya que cuenta con una duración de 3 años y contiene 68 mg de etonogestrel. Tiene una tasa de falla de 0.05 embarazos por cada 100 mujeres que lo usan ⁵³.

El inyectable de sólo progestina o trimestral viene en la presentación de acetato de medroxiprogesterona de 150 mg por 1 ml y se debe administrar vía intramuscular en la región glútea con la técnica en Z. Se empieza a administrar este método entre el primer y quinto día de menstruación y se continúa con la siguiente dosis en 3 meses. Este método tiene una tasa de falla de uso perfecto de 0.3 embarazos por cada 100 mujeres que lo usan ^{50,53}.

Métodos anticonceptivos hormonales e incremento de peso

El uso de métodos anticonceptivos hormonales se ha asociado con la aparición de algunos efectos secundarios tales como cefaleas, cambios

de apetito, irregularidades en el ciclo menstrual, amenorrea, mastalgia, acné, dolor abdominal, alteraciones en el peso, entre otros ⁵⁰.

El aumento de peso relacionado al uso de anticonceptivos hormonales se debe principalmente al efecto de las hormonas estrógeno y progestágeno sobre la fisiología de la mujer. Por un lado, el estrógeno influye en el metabolismo de los lípidos, lo que puede resultar en un mayor incremento en las reservas de grasa corporal. Además, se ha encontrado que ocasiona retención de líquidos lo que también tiene un efecto en el peso. Por otro lado, la progesterona tiene acción sobre el control del apetito a nivel de la corteza cerebral, el hipotálamo y el tronco encefálico. Adicionalmente al incremento de apetito, la progesterona también facilita los procesos metabólicos de conversión de carbohidratos en grasa, lo que resultaría en una mayor reserva de grasa y ganancia de peso ⁵⁶⁻⁵⁸.

Se ha evidenciado que el uso de anticonceptivos hormonales ha generado un aumento de peso en las mujeres que lo utilizan que varía desde 0.3 kg hasta 5 kg según el tiempo de uso y presentación ¹¹.

Algunos estudios han encontrado que la ganancia de peso promedio con el uso de anticonceptivos hormonales de solo progestina puede presentar una ganancia de 2kg en un periodo de 6 meses o una ganancia de 3 kg en un año mientras que en un periodo de hasta 10 años puede llegar hasta los 10kg ^{59,60}.

En el caso del inyectable trimestral (acetato de medroxiprogesterona) se han registrado variaciones en el índice de masa corporal (IMC) de las usuarias tras un año de uso donde aquellas que tenían un IMC normal terminaron con sobrepeso y las que empezaron con sobrepeso resultaron con obesidad tipo I. Asimismo, las mujeres con IMC de bajo peso, normal y sobrepeso incrementaron un aproximado de 5 kg en comparación a su peso inicial; mientras que aquellas con obesidad tipo I ganaron 4 kg ⁶¹. También se han encontrado evidencias de un incremento hasta de 3 kg

en periodos de 3 y 6 meses de uso; mientras que al año existen registros de mujeres que han subido 6 kg, 9 kg y más de 9 kg ⁶².

El implante puede presentar un incremento de peso de 2.4kg en un periodo de uso de 18 meses, mientras que la ampolla trimestral de acetato de medroxiprogesterona puede ocasionar una ganancia de 3.5 kg ⁶³. En un estudio realizado en adultas con distintos índices de masa corporal antes y después de un año con el uso del implante se encontró que las mujeres con delgadez presentaron un incremento de 1-2 kg; mujeres con un IMC normal, sobrepeso y obesidad ganaron menos de 1kg ⁶⁴. Sin embargo, también se han registrado casos de usuarias que han presentado ganancia de peso en promedio de 6,2 kg con un mínimo de 4 kg y un máximo de 9,5 kg incrementados tras un año de uso ⁶⁵.

El incremento de peso se ha podido evidenciar como efecto secundario al uso de métodos hormonales, no obstante, otro factor que interviene en la ganancia de peso es el tipo de estilo de vida que la usuaria presente. Una mujer que tenga un estilo de vida con poca o nula actividad física, así como una alimentación rica en carbohidratos y grasas saturadas estaría más predispuesta a ganar peso. Ambos factores podrían resultar perjudiciales para la salud de las mujeres.

II. 3. Definición de términos:

- Índice de masa corporal: medida que se calcula al dividir el peso de una persona en kilogramos entre el cuadrado de su altura en metros. Este número permite clasificar el peso de una persona como bajo peso, normal, sobrepeso y obesidad (I, II y III) ⁶⁶.
- Derechos sexuales: se refiere al cumplimiento de los derechos humanos que estén relacionados con la sexualidad y salud sexual. Estos permiten y protegen el derecho de toda persona para satisfacer y expresar su sexualidad, así como disfrutar su salud sexual ⁶⁷.

- Intensidad de actividad física: se refiere al grado en que se realiza una actividad, o la magnitud de esfuerzo que se necesita para poder realizar una actividad o ejercicio ⁴⁹.
- Salud reproductiva: es el estado general de bienestar, tanto físico como mental y social. No se limita a la ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo, funciones y procesos ⁶⁸.
- Salud sexual: se refiere al estado de bienestar general, tanto físico como mental y social con respecto a la sexualidad. Asimismo, esta no se limita a la ausencia de enfermedades, disfunción o incapacidad ⁶⁷.
- Sexualidad: dimensión o aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. La sexualidad incluye al “sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual” ⁶⁷.

III. HIPÓTESIS Y VARIABLES

III.1. Hipótesis

El estudio no requiere una hipótesis, ya que es de tipo descriptivo.

III.2. Variable

Variable de estudio:

Estilos de vida

Variable interviniente:

Peso durante el periodo de uso del método anticonceptivo hormonal

III.3. Operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Tipo y escala	Valor final
Estilos de vida	Forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los patrones individuales de conducta determinados por factores socioculturales y características personales ²³ .	Patrones conductuales o hábitos en relación a la salud de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales que han incrementado de peso.	Alimentación	Frecuencia de consumo de cereales y derivados	Cualitativa y ordinal	• Nunca • A veces • Frecuentemente • Rutinariamente
				Frecuencia de consumo de verduras y hortalizas		
				Frecuencia de consumo de frutas		
				Frecuencia de consumo de leche y derivados		
				Frecuencia de consumo de carnes y huevos		
				Frecuencia de consumo de leguminosas		

				Frecuencia de consumo de embutidos y jamones		
				Frecuencia de consumo de dulces y bebidas azucaradas		
				Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas		
			Actividad física	Intensidad	Cualitativa y ordinal	• Leve • Moderada • Vigorosa
				Frecuencia por semana		• 1-3 días • 3-4 días • 5-6 días • 7 días • Ningún día
				Duración		• Menos de 30 minutos • Entre 30 minutos y 1 hora • Más de 1 hora • No realiza actividad física

IV. MATERIALES Y MÉTODOS

IV. 1. Tipo de estudio

La investigación fue de tipo observacional (no experimental) con enfoque cuantitativo.

IV.2. Diseño de estudio

El diseño del estudio fue de tipo descriptivo, transversal y prospectivo.

IV.3. Población

Mujeres usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, durante los meses de octubre y noviembre de 2024.

Unidad de análisis

Usuaría de método anticonceptivo hormonal con incremento de peso atendida en el servicio de planificación familiar del Centro Materno Infantil Surquillo durante los meses de estudio.

Criterios de inclusión

- Mujeres usuarias continuadoras de métodos anticonceptivos hormonales que acudan a sus citas de control en el servicio de Planificación Familiar.
- Mujeres que usen un método anticonceptivo hormonal por un periodo mínimo de 3 meses hasta el momento del estudio.
- Mujeres mayores de 18 años.
- Mujeres que hayan firmado el consentimiento informado.
- Mujeres usuarias que hayan incrementado mínimo 3kg hasta el momento del estudio para que se permita evidenciar el efecto de incremento de peso en las usuarias.

- Mujeres usuarias de métodos hormonales, cuyo peso esté consignado desde el inicio del uso en su tarjeta de control o historia clínica.

Criterios de exclusión

- Mujeres que al momento de la evaluación le han diagnosticado gestación.
- Mujeres que acudan al servicio de planificación familiar con el fin de tratamiento ginecológico.
- Mujeres puérperas.
- Mujeres que decidan retirarse del estudio.

IV.4. Muestra

La muestra del estudio fue de tipo censal y estuvo conformada por 43 usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso durante los 2 meses que se realizó la recolección de datos y que cumplieron con los criterios de selección.

Tipo de muestreo

No probabilístico.

IV.5. Técnica

La técnica que se aplicó en este estudio para obtener información de los estilos de vida fue la encuesta, la cual se realizó con previo consentimiento informado y aceptación de la participación en el estudio por parte de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales.

Para la obtención de la información con respecto al incremento de peso se empleó una técnica documental debido a que se revisaron las historias clínicas y tarjetas de control de planificación familiar de las usuarias para verificar la información relacionada al método anticonceptivo y el incremento de peso.

IV.6. Instrumento de recolección de datos

La evaluación de la variable estilo de vida utilizó dos instrumentos validados para medir las dimensiones de alimentación y actividad física. Para la dimensión alimentación se utilizó el “Cuestionario de índice de alimentación saludable”. El cuestionario considera el consumo de nueve grupos de alimentos (cereales y derivados, verduras y hortalizas, frutas, leche y derivados, carnes y huevos, leguminosas, embutidos y jamones, dulces y refrescos con azúcar, bebidas alcohólicas) y la puntuación está en relación a la frecuencia del consumo de cada grupo de alimentos, pudiendo obtener una puntuación entre 0-10 puntos. El instrumento es una adaptación al español del instrumento norteamericano “The Healthy Eating Index” de Basiotis P. et al ⁶⁹. Romero- Berrocal Y. y López-Ponce C. validaron el instrumento en Perú por juicio de expertos y calcularon la confiabilidad del cuestionario por medio de una prueba piloto en un grupo de jóvenes, de la cual obtuvieron un α de Cronbach de 0,79. Los resultados del cuestionario dan como valores “Poco saludable”, “necesita cambios” y “saludable” ⁷⁰.

La dimensión de actividad física fue medida por medio la versión corta en español del Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) de Craig et. al (International physical activity questionnaire)⁷¹. Asimismo, el instrumento fue validado en Perú por Lecca Marreros I. y Cuevas Reyes E. quienes realizaron una prueba piloto a un grupo de jóvenes universitarios de Lima Este y obtuvieron un α de Cronbach de 0,74 ⁷². El cuestionario considera 3 características esenciales de la actividad física tales como la intensidad (leve, moderada y vigorosa), frecuencia (número de días en la semana realizando la actividad física) y duración (tiempo que realiza la actividad física por día). La fiabilidad estimada del instrumento es de 0,65 ($r = 0,76$; IC 95 %: 0,73-0,77) ⁷³.

Por último, se utilizó la hoja de registro que Ramos elaboró en 2017 para registrar la variación del peso e índice de masa corporal en usuarias de planificación familiar del Instituto Nacional Materno Perinatal en Lima y la

cual fue validada por juicio de expertos. La autora estimó el coeficiente de correlación de concordancia obteniendo un valor de 0.93 ⁶⁴.

IV.7. Procedimientos

Se solicitó la evaluación del Comité de Investigación de la Escuela Profesional de Obstetricia y se realizaron los ajustes indicados por el comité. Posterior a la aprobación, la Escuela Profesional de Obstetricia solicitó la resolución decanal de la Facultad de Medicina. Con los permisos obtenidos se acudió al Comité Institucional de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para obtener el informe del comité de ética. Posterior a la aprobación del comité de ética, se presentó el proyecto de investigación al Comité de Investigación de la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima Centro.

Una vez obtenido el acta de aprobación, la DIRIS Lima Centro envió un documento dirigido al médico jefe del establecimiento para permitir el acceso a la población de estudio y al sistema de historias clínicas. Asimismo, se conversó con la jefa de obstetras y las obstetras del centro de salud para poder ingresar al servicio de planificación y captar a las usuarias del servicio para la recolección de datos.

Se informó a las usuarias sobre el objetivo de la investigación y se le solicitó a todas su consentimiento para participar de manera anónima en el estudio. Una vez obtenido el consentimiento informado de las usuarias se les aplicó el cuestionario. Cuando se culminó con la recolección de datos se realizó una base de datos en Excel para su posterior análisis.

IV.8. Análisis de datos

Se recolectó la data en una computadora de uso personal. Se hizo uso del programa de Excel para las mediciones de estadística descriptiva tales como la frecuencia, proporciones y medidas de tendencia central en

relación al uso de métodos anticonceptivos, actividad física y alimentación. Además, se realizaron las tablas en el mismo programa.

IV.9. Consideraciones éticas

La investigación fue presentada al Comité Institucional de Ética en Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para su aprobación. El estudio respetó los cuatro principios éticos de investigación en ciencias de la salud. En primer lugar, se cumplió con el principio de no maleficencia debido a que el estudio no buscó ni tuvo intenciones de ocasionar algún tipo de daño a las usuarias ni por medio de su información brindada, la cual será confidencial y de forma anónima. En segundo lugar, se respetó el principio de beneficencia, ya que los resultados obtenidos podrían contribuir al servicio de planificación familiar y el establecimiento de salud, permitiendo que en un futuro las usuarias puedan verse beneficiadas con mejoras en su atención. Asimismo, se les brindó orientación sobre la importancia de los estilos saludables y recomendó acudir al servicio de nutrición a fin de mejorar su alimentación. También se cumplió con el principio de autonomía porque se le realizó un consentimiento informado a cada una de las participantes, el cual podía ser retirado si es que lo solicitaban. Por último, el principio de justicia se respetó porque todas las participantes recibieron el mismo trato durante la recolección de datos.

V. RESULTADOS

Tabla N° 1: Características sociodemográficas de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024

Características sociodemográficas	n	%
Edad		
18 - 29 años	28	65,1
30 - 49 años	15	34,9
> 49 años	0	0,0
Estado civil		
Soltera	35	81,4
Casada	8	18,6
Viuda	0	0,0
Divorciada	0	0,0
Ocupación actual		
Trabajador dependiente	27	62,8
Trabajador independiente	7	16,3
No trabaja actualmente	5	11,6
Estudiante	4	9,3
Nivel educativo		
Sin estudios	0	0,0
Inicial	0	0,0
Primaria incompleta	0	0,0
Primaria completa	1	2,3
Secundaria incompleta	4	9,3
Secundaria completa	12	27,9
Superior incompleta	17	39,5
Superior completa	9	20,9
Religión		
Católica	32	74,4
Evangélica	4	9,3
Adventista	0	0,0
Testigo de Jehová	0	0,0
Agnosticismo	1	2,3
Ateísmo	3	7,0
Otro	3	7,0
Lengua materna		
Castellano	43	100,0
Quechua	0	0,0
Aimara	0	0,0
Otra lengua aborigen	0	0,0
Otra lengua extranjera	0	0,0
Nacionalidad		

Peruana	37	86,0
Venezolana	6	14,0
Otra	0	0,0
Total	43	100

La **tabla N° 1** muestra que el 65,1% de las usuarias pertenece al grupo etario de jóvenes (18 a 29 años), el 81,4% es soltera, y el 62,8% es trabajadora dependiente o empleada. La mayoría tiene educación superior incompleta (39,5%) y el 74,4% es de religión católica. Además, el 14% de las usuarias es de nacionalidad venezolana.

Tabla N° 2: Datos reproductivos de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024

Datos reproductivos	n	%
Menarquía		
8 -10 años	6	13,95
11 - 13 años	28	65,12
14 - 16 años	8	18,60
Más de 17 años	1	2,33
Inicio de relaciones sexuales		
11 - 13 años	3	6,98
14 - 16 años	12	27,91
17 - 19 años	19	44,19
20 - 25 años	9	20,93
Más de 25 años	0	0,00
Número de parejas sexuales		
1 - 2	27	62,79
3 - 4	10	23,26
5 - 10	5	11,63
Más de 10	1	2,33
Número de embarazos		
Ninguno	19	44,19
1 - 2	15	34,88
3 - 4	6	13,95
Más de 5 embarazos	3	6,98
Total	43	100

La **tabla N° 2** muestra que el 65,12% de las usuarias tuvo su primera menstruación entre los 11 y 13 años. El 44,19% inició sus relaciones sexuales entre los 17 y 19 años, y el 27,91% entre los 14 y 16 años. Además, el 62,79% reportó tener 1 o 2 parejas sexuales, y el 44,19% no tiene hijos ni ha estado embarazada.

Tabla N° 3: Características del uso de métodos anticonceptivos hormonales de las usuarias con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024

Características del uso de método anticonceptivo hormonal	n	%
Método anticonceptivo		
Anticonceptivo oral combinado	5	11,63
Inyectable/ampolla mensual	19	44,19
Inyectable/ampolla trimestral	12	27,91
Implante subdérmico	7	16,28
Tiempo de uso		
Menos de un año	8	18,60
1 - 2 años	27	62,79
2 - 3 años	6	13,95
Más de 3 años	2	4,65
Efectos secundarios referidos por las usuarias		
Cefalea	9	10,00
Cambios en el apetito (incremento)	32	35,56
Ciclos menstruales irregulares	12	13,33
Amenorrea	1	1,11
Mastalgia	1	1,11
Náuseas	6	6,67
Acné	3	3,33
Alteraciones en el peso	12	13,33
Dolor abdominal	12	13,33
Otro	2	2,22
Ninguno	0	0,00
Total	43	100

La **tabla N° 3** muestra que el método anticonceptivo hormonal más utilizado por las usuarias son los inyectables mensuales (44,19%), seguido por los inyectables trimestrales (27,91%). Además, el 62,79% de las usuarias había estado

utilizando su método entre 1 y 2 años. El efecto secundario más reportado fue el incremento de apetito, mencionado por el 35,56% de las pacientes.

Tabla N° 4: Usuarías de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024

Método anticonceptivo	Incremento de peso				
	Presenta		No presenta		Total
	n	%	n	%	n
Anticonceptivos orales combinados	5	26,32	14	73,68	19
Inyectable mensual	19	20,21	75	79,79	94
Inyectable trimestral	12	16,44	61	83,56	73
Implante subdérmico	7	46,67	8	53,33	15
Total	43	21,39	158	78,61	201

La **tabla N° 4** muestra que el 21,9% de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales han aumentado de peso. Esta proporción incluye el 26,32% de usuarias de anticonceptivos orales combinados, 20,21% del inyectable mensual, 16,44% del inyectable trimestral y el 46,67% del implante subdérmico.

Tabla N° 5: Medidas antropométricas de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024

Medidas antropométricas	Medidas de tendencia central		
	Media (DE)	Mediana	Moda
Talla	1,57 (0,07)	1,58	1,6
Peso al inicio	64,53 (11,08)	64	54
Peso al momento de la recolección	73,27 (11,06)	73,2	61
Incremento de peso	8,69 (4,83)	7	5

*DE = Desviación estándar

En la **tabla N° 5** se muestra que la talla promedio de las usuarias es de 1,57 m. Al inicio del uso del método, el peso promedio era de 64,53 kg, y al momento de la recolección de datos, aumentó a 73,27 kg, y se estimó un incremento promedio de 8,69 kg con una mediana de 7 kg. Adicionalmente, el aumento de peso más frecuente entre las participantes fue de 5 kg.

Tabla N° 6: Variación de índice de masa corporal (IMC) de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024

Clasificación	Índice de masa corporal			
	Inicio de uso		Momento de recolección	
	n	%	n	%
Normal	19	44,19	6	13,95
Sobrepeso	14	32,56	17	39,53
Obesidad tipo I	9	20,93	13	30,23
Obesidad tipo II	1	2,33	7	16,28
Total	43	100	43	100

En la **tabla N° 6** se muestra la variación del índice de masa corporal (IMC) que tenían las usuarias al inicio de uso de su método anticonceptivo hormonal en comparación con el IMC al realizar el estudio. Se encontró que 44,2 % tenía un IMC normal, 32,6% se encontraba en sobrepeso, 20,9% tenía obesidad tipo I y 2,33% obesidad tipo II. Al momento de la recolección se incrementó en un 6,9% la proporción de usuarias con IMC de sobrepeso (39,5%); un 9,3% la frecuencia de usuarias con obesidad tipo I (30%) y aumentaron en un 13,97% las usuarias con obesidad tipo II.

Tabla N° 7: Incremento de peso de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024

Incremento de peso	n	%
3 - 5 kg	4	9,30
5 - 10 kg	27	62,79
Más de 10 kg	12	27,91

En la **tabla N°7** se puede observar que gran parte de las usuarias aumentó más de 5kg posterior al uso de algún método anticonceptivo hormonal.

Tabla N° 8: Incremento de peso según índice de masa corporal (IMC) de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024

Clasificación por IMC	n	%
Normal		
3 - 5 kg	1	5,26
5 - 10 kg	12	63,16
Más de 10 kg	6	31,58
Sobrepeso		
3 - 5 kg	3	21,43
5 - 10 kg	7	50,00
Más de 10 kg	4	28,57
Obesidad tipo I		
3 - 5 kg	0	0,00
5 - 10 kg	7	77,78
Más de 10 kg	2	22,22
Obesidad tipo II		
3 - 5 kg	0	0
5 - 10 kg	1	100
Más de 10 kg	0	0

La **tabla N° 8** indica que el 63,16% de las usuarias con IMC normal aumentó entre 5 y 10 kg. De manera similar, el 66,67% de las usuarias con sobrepeso, el 85,71% con obesidad tipo I y el 100% con obesidad tipo II también incrementaron su peso en este rango. Además, se registraron casos de usuarias con IMC normal que ganaron entre 10,7 y 27,5 kg, aquellas con sobrepeso que aumentaron de 15 a 20,5 kg, y usuarias con obesidad tipo I que subieron 14,9 kg.

Tabla N° 9: Incremento de peso según método anticonceptivo utilizado de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024

Método anticonceptivo hormonal utilizado	Incremento de peso	
	n	%
Anticonceptivos orales combinados		
3 - 5 kg	0	0,00
5 - 10 kg	4	80,00
Más de 10 kg	1	20,00
Inyectable/ampolla mensual		
3 - 5 kg	2	10,53
5 - 10 kg	11	57,89
Más de 10 kg	6	31,58
Inyectable/ampolla trimestral		
3 - 5 kg	1	8,33
5 - 10 kg	10	83,33
Más de 10 kg	1	8,33
Implante subdérmico		
3 - 5 kg	1	14,29
5 - 10 kg	2	28,57
Más de 10 kg	4	57,14

Con respecto al incremento de peso y el tipo de método utilizado, la **tabla N° 9** muestra que 80% de las usuarias de anticonceptivos orales combinados; 57,89% de inyectable mensual y 83,33% de inyectable trimestral ganaron entre 5 y 10 kg. Por otro lado, con el implante el 57,14% subió más de 10 kg.

Tabla N° 10: Tipo de alimentación de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024

Tipo de alimentación	n	%
Alimentación poco saludable	2	4,65
Necesita cambios	41	95,35
Alimentación saludable	0	0

La **tabla N° 10** muestra que gran parte de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales presenta una alimentación que necesita cambios para ser considerada una alimentación saludable (95,35%) y que ninguna llega a presentar una alimentación considerada como saludable.

Tabla n° 11: Frecuencia de consumo de alimentos de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024

Grupo de alimento	Frecuencia de consumo							
	Nunca o casi nunca		Menos de 1 vez a la semana		1 o 2 veces a la semana		3 a 7 veces a la semana	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Cereales y harinas	1	2,33	4	9,30	8	18,60	30	69,77
Verduras y hortalizas	1	2,33	4	9,30	10	23,26	28	65,12
Frutas	2	4,65	6	13,95	16	37,21	19	44,19
Leche y derivados (lácteos)	6	13,95	0	0,00	10	23,26	27	62,79
Carnes y huevos	0	0,00	0	0,00	6	13,95	37	86,05
Legumbres	2	4,65	5	11,63	17	39,53	19	44,19
Embutidos y jamones	3	6,98	6	13,95	17	39,53	17	39,53
Dulces y gaseosas	4	9,30	4	9,30	9	20,93	26	60,47
Bebidas alcohólicas	21	48,84	20	46,51	1	2,33	1	2,33

La **tabla N° 11** muestra que las usuarias consumen con mayor frecuencia carnes y huevos (86,05%), verduras y hortalizas (65,12%) y lácteos (62,79%). Sin

embargo, también se observa un alto consumo de "comida chatarra", como dulces y gaseosas (60,47%) y embutidos (39,53%), así como un gran consumo de harinas (69,77%).

Tabla N° 12: Nivel de actividad física de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024

Nivel de actividad física	n	%
Bajo	14	32,56
Moderado	21	48,84
Alto	8	18,60

La **tabla N°12** indica el nivel de actividad física de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales que presentaron incremento de peso y en esta se puede reflejar que 48,84% tenía un nivel de actividad física moderado y 32,56% cuenta con un nivel bajo.

Tabla N ° 13: Tipo de actividad física realizada por semana de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024

Tipo de actividad física realizada por semana		n	%
Actividad física vigorosa	Frecuencia		
	Ningún día	29	67,44
	1 - 2 días	7	16,28
	3 - 4 días	2	4,65
	5 a más días	5	11,63
	Duración		
	Menos de 30 minutos	1	7,14
	30 - 60 minutos	10	71,43
	Más de 1 hora	3	21,43
Actividad física moderada	Frecuencia		
	Ningún día	33	76,74
	1 - 2 días	7	16,28
	3 - 4 días	0	0,00
	5 a más días	3	6,98

	Duración		
	Menos de 30 minutos	0	0,00
	30 - 60 minutos	4	40,00
	Más de 1 hora	6	60,00
Actividad física leve	Frecuencia		
	Ningún día	5	11,63
	1 - 2 días	7	16,28
	3 - 4 días	4	9,30
	5 a más días	27	62,79
	Duración		
	Menos de 30 minutos	8	21,05
	30 - 60 minutos	20	52,63
	Más de 1 hora	10	26,32
Actividades sedentarias	Tiempo en un día		
	Menos de 30 minutos	2	4,65
	30 - 60 minutos	6	13,95
	1 - 2 horas	0	0,00
	2 - 5 horas	21	48,84
	Más de 5 horas	14	32,56

La **tabla N° 13** muestra que el 67,44% de las usuarias no realizaba actividad física vigorosa, y entre las que sí, el 71,43% la practicaba de 30 a 60 minutos, con un promedio de 63 minutos. El 76,74% no realizó actividad física moderada, y entre las que lo hicieron, el 60% invirtió más de 1 hora, promediando 104 minutos. Con relación a la actividad física leve, el 62,79% caminó 5 o más días a la semana, dedicando el 52,63% entre 30 y 60 minutos, con un promedio de 70 minutos. Por último, casi el 80% dedicó más de 2 horas a actividades sedentarias, con un promedio de 248 minutos.

VI. DISCUSIÓN

Las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales presentan hábitos y rutinas de alimentación y actividad física que forman parte de su estilo de vida, lo cual repercute en su salud. Estos estilos de vida pueden estar influenciados por diversas características sociodemográficas tales como la edad, el estado civil, el nivel o grado educativo y la ocupación.

Se ha encontrado que la mayoría de las usuarias tiene de 18 a 29 años, son solteras, son trabajadoras empleadas y tienen un nivel educativo de superior incompleta. Estas características encontradas pueden afectar su actividad diaria y, en consecuencia, limitar o favorecer la adopción de prácticas propias de un estilo de vida saludable.

Se encontró que 21,39% de las usuarias de anticonceptivos hormonales que fueron atendidas durante los meses de octubre y noviembre presentaron incremento de peso. De este grupo, se halló que más de la mitad de usuarias subieron más de 5 kg tras el uso de alguno de estos métodos (62,70%), y 27,91% subió más de 10kg. En contraste, el grupo de usuarias de métodos anticonceptivos hormonales estudiados por Díaz Chavez V. y Hernández Cañeda R. mostró un aumento de peso menor, el cual se situó mayormente en un rango de 1 a 5 kg ¹⁹.

En cuanto al incremento de peso según el método anticonceptivo hormonal utilizado, la mayor parte de las usuarias de las pastillas anticonceptivas, inyectable mensual e inyectable trimestral incrementaron entre 5 a 10 kg; mientras que con el implante subdérmico se subió más de 10 kg. Estos resultados coinciden con los hallazgos de Serrano Casilla L. ⁷⁴ quien menciona que 36,6% de usuarias del inyectable trimestral subieron entre 5 a 7 kg. Por el contrario, los resultados de la presente investigación se contradicen con los de Velasquez Capristan M.²², quien encontró que posterior al uso del inyectable trimestral la mayor parte de su población subió de menos de 2 kilos a 4 kg. A pesar de las diferencias observadas en el incremento de peso, es importante

señalar que, en todos los casos, se presenta alguna variación, aunque esta es menor en ciertos contextos. Esta variación podría estar influenciada por diversos factores relacionados con el uso del método anticonceptivo, tales como el tipo de anticonceptivo utilizado y la duración de su uso. Además, por características que difieren con los hallazgos del presente estudio como la edad mayor a 30 años, la ocupación de ama de casa y el nivel educativo de secundaria podrían afectar los hábitos de salud de las usuarias, incidiendo en la posibilidad de evitar o favorecer el incremento de peso. Sin embargo, es relevante mencionar que no se ha podido contrastar los hábitos o el estilo de vida en estos otros estudios, dado que los investigadores no han abordado esta temática en sus investigaciones.

En referencia al incremento de IMC, se encontró que hubo un incremento de la proporción de usuarias con sobrepeso, obesidad tipo I y tipo II, mientras que las mujeres con IMC normal disminuyeron en un 30%. Estos resultados son semejantes a los encontrados por Ustua Sanchez T.²⁰ Velasquez Capristan M.²², Flores Ormeño M. y Rojas Vera M.¹⁷ quienes también coincidieron que la proporción de usuarias con sobrepeso y obesidad incrementaron sus cifras, mientras que las usuarias con IMC normal disminuyeron. Se puede apreciar que, en gran parte de las usuarias, el incremento de peso tiene un efecto negativo en su índice de masa corporal llegando en muchos casos al rango de sobrepeso y obesidad. Esta situación podría ser un riesgo para su salud en el futuro, especialmente si las usuarias permanecen en estos rangos o experimentan un aumento adicional de peso.

Los resultados sobre el estilo de vida en la dimensión alimentación muestran que 95,35% de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales tiene una alimentación que necesita cambios para que pueda ser saludable. A pesar de que el tipo de alimentación alcanzada por las usuarias de anticonceptivos hormonales no es considerado poco saludable o no saludable, este no llega a cumplir con los criterios para ser una alimentación saludable. Este hallazgo es más favorable que el encontrado por Morales Laurente N. en Huancavelica, cuya población de usuarias de anticonceptivos presentó en su mayoría una alimentación deficiente siendo esta un 65,6% ²¹. De forma contraria, la población

chilena del estudio de Orbe Orozco S. refiere presentar una mejor alimentación. Los resultados de Orbe Orozco S. señalan que 44% a veces tiene una alimentación balanceada y 42% casi siempre mientras que en el presente estudio no se encontraron usuarias que logren alcanzar una alimentación saludable ¹⁶.

Los alimentos que son considerados “comida chatarra” como los embutidos y jamones, dulces y gaseosas fueron consumidos de 3 a 7 veces por semana en un 39,53% y 60,47% respectivamente. A pesar de que Orbe Orozco S. refiere que su población tiene una mejor alimentación, en su estudio también menciona que más de la mitad de las mujeres de su estudio (63,8%) consume mucha comida chatarra, con alto contenido de sal y dulces ¹⁶.

El tipo de alimentación se puede ver influenciada por el distinto contexto sociocultural y económico de las usuarias, pudiéndose presentar un resultado más favorable en relación a un tipo de alimentación saludable en otro país. No obstante, se puede ver que en el consumo de alimentos no saludables es mayor a la frecuencia que debería tener que es de forma ocasional o reducida en ambos casos.

Los hallazgos en torno a la actividad física muestran que 48,84% tenía un nivel de actividad física moderado, 32,56% cuenta con un nivel bajo y 18,60% tiene un nivel alto de actividad física. Similarmente, Orbe Orozco encontró que 35,5 % no realiza ningún tipo de actividad física. En contraste con los hallazgos del estudio, Morales Laurente N. encontró una mayor proporción de usuarias de planificación familiar con un 60,7% que tiene un nivel de actividad física deficiente. Además, la investigadora determinó que 29,5% presenta un nivel suficiente y solo 9,8% alcanzó un nivel saludable ²¹. A comparación del estudio de Morales, la población del presente trabajo presenta un mejor nivel de actividad física, no obstante, la proporción de un nivel alto o saludable es menor en ambos grupos.

La mayoría de usuarias que realiza actividades físicas vigorosas lo hacen por 1 a 2 días con una duración de 30 a 60 minutos y con una duración promedio de 63 minutos. En el caso de la actividad física moderada, gran parte las realiza

más de una hora con un promedio de 104 minutos de duración. Además, se pudo encontrar que gran parte de las usuarias realiza caminatas de 5 a más días con una duración de 30 a 60 minutos por día.

En relación a la duración de la actividad física, la Organización Mundial de la Salud indica que las actividades físicas vigorosas deben realizarse entre 75 a 150 minutos semanalmente por lo que la mayoría de usuarias del estudio que sí realizaban estas actividades cumplen con lo mínimo que se recomienda al realizar en su mayoría un promedio de 63 minutos hasta por 2 días. Paralelamente con respecto a las actividades moderadas, las usuarias que sí realizaron este tipo de actividades invirtieron un promedio de 104 minutos en estas por 1 a 2 días y algunas incluso las realizaron por más de 5 días por lo que alcanzan a cumplir con el tiempo mínimo por semana requerido por la OMS ^{48,49}. Sin embargo, se debe destacar que estas cifras son solo de la minoría que sí realizaba actividades físicas mientras que casi un 80% realizaba actividades sedentarias. A pesar de que la mayoría de mujeres que usa anticonceptivos hormonales tiene un nivel de actividad física entre moderado y bajo, existen algunas que realizan actividades vigorosas y moderadas llegan a cumplir con lo mínimo que recomienda la OMS para tener un estilo de vida saludable.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- Las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso presentan un estilo de vida que necesita realizar mejoras para llegar a un nivel saludable.
- Existen usuarias de métodos anticonceptivos hormonales que han presentado un incremento de peso entre 5 a 10 kg a partir de los 3 meses de uso.
- Las usuarias presentaron un incremento de su índice de masa corporal, predominando una mayor proporción de usuarias con IMC de sobrepeso y obesidad tipo I a partir de los 3 meses de uso.
- En cuanto al estilo de vida sobre la alimentación de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso, la mayoría tiene una alimentación que necesita cambios para que pueda ser saludable y ninguna alcanzó el nivel de una alimentación saludable. La alimentación de las usuarias se caracteriza en su mayoría por un alto consumo de comida no saludable como embutidos, jamones, dulces y gaseosas.
- En cuanto al estilo de vida sobre la actividad física, la mayoría de las usuarias alcanzó un nivel que se sitúa entre moderado y bajo. Además, dedicaban mucho tiempo a realizar actividades sedentarias. Sin embargo, es importante destacar que algunas de ellas lograron realizar actividades físicas el tiempo mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para mantener una buena salud.

Recomendaciones:

- Se recomienda promover estilos de vida saludables a todas las mujeres en edad fértil que se atienden en el establecimiento, sean estas usuarias de planificación familiar u otros servicios para prevenir el incremento de sobrepeso y obesidad. Esto se podría realizar con ayuda de los agentes comunitarios de salud en los ambientes de espera del establecimiento para captar una mayor cantidad de mujeres que puedan presentar alguno de estos riesgos.
- Se sugiere optimizar el control existente del peso antes y durante el uso de anticonceptivos hormonales, incentivando que el personal de salud no sólo registre el incremento de peso en las usuarias que lo presenten, sino que actúe de manera oportuna. Esto incluye la implementación de un protocolo para la identificación temprana, consejería en estilos de vida saludables y monitoreo continuo por medio de un registro o cuaderno de seguimiento.
- Se plantea incentivar una mayor articulación entre los servicios de planificación familiar, nutrición, medicina y admisión del establecimiento, con el fin de establecer una ruta de atención integral que agilice la interconsulta para las usuarias identificadas con sobrepeso u obesidad. Esta coordinación debe incluir un seguimiento por parte de cada servicio para evaluar el cumplimiento de los tratamientos y acuerdos establecidos, así como el monitoreo de posibles mejoras en el estado de salud de las usuarias.
- Se propone capacitar y actualizar al personal de planificación familiar en la detección de hábitos alimenticios poco saludables y en consejería nutricional, fortaleciendo sus competencias para una atención integral. Esto incluye el uso de instrumentos que evalúen su alimentación para una detección oportuna, así como la realización de una primera consulta que facilite la derivación con un especialista.
- Se recomienda implementar actividades de promoción de la actividad física dirigidas a mujeres con sobrepeso y obesidad, en un trabajo coordinado entre el establecimiento de salud y la municipalidad. Estas

iniciativas pueden incluir la difusión de campañas publicitarias a favor de la actividad física en espacios públicos y redes sociales de la municipalidad, así como la habilitación y adecuación de espacios públicos destinados específicamente para la práctica de actividad física.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Organización Panamericana de la Salud. Prevención de la obesidad - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. Organización Panamericana de la Salud. 2023 [citado 13 de septiembre de 2023]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/temas/prevencion-obesidad>
2. Instituto Nacional de Estadística e Informática. PERÚ: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y TRANSMISIBLES, 2022 [Internet]. 2023. Disponible en: https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2022/SALUD/ENFERMEDADES_ENDES_2022.pdf
3. Organización Mundial de la Salud. Obesidad y sobrepeso [Internet]. Organización Mundial de la Salud. 2021 [citado 13 de septiembre de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
4. Instituto Peruano del Deporte. Encuesta sobre Actividad Física y Hábitos de Vida Saludable [Internet]. Lima, Perú: Instituto Peruano del Deporte; 2021. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/ipd/campa%C3%B1as/11524-encuesta-nacional-2021>
5. Instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Informe Técnico de la Vigilancia Alimentaria Nutricional por Etapas de Vida: Adultos [Internet]. Instituto Nacional de Salud; 2023. Disponible en: <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/estado-nutricional-en-adultos-de-18-59-a%C3%B1os-per%C3%BA-2017-%E2%80%93-2018>
6. Fondo de Población de las Naciones Unidas. Planificación Familiar [Internet]. UNFPA América Latina y el Caribe. 2014 [citado 13 de septiembre de 2023]. Disponible en: <https://lac.unfpa.org/es/temas/planificaci%C3%B3n-familiar>
7. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2022 - Nacional y Departamental [Internet]. 2023. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1898/libro.pdf
8. Ku E. Causas de necesidad insatisfecha en planificación familiar en mujeres con embarazo no deseado del Instituto Nacional Materno Perinatal. Rev Peru Epidemiol [Internet]. 2010 [citado 22 de junio de 2023];14(2):124-32. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203119666006>
9. Flores-Cortez D, Villalobos-Pacheco E, Alfonso-Flores I. Reacciones adversas asociadas al empleo de anticonceptivos hormonales en usuarias de Lima metropolitana, Mayo-Junio 2018. Rev Int Salud Materno Fetal [Internet]. 30 de

- septiembre de 2019 [citado 22 de junio de 2023];4(3):19-26. Disponible en: <http://ojs.revistamaternofetal.com/index.php/RISMF/article/view/110>
10. Gutiérrez-Crespo H, Huaman-Carhuas L, Cehua-Alvarez EA, Matzumura-Kasano JP, Valdeiglesias-Ochoa D, Gutiérrez-Crespo H, et al. Adherencia y barreras en el uso de anticonceptivos en mujeres adultas jóvenes atendidas en establecimientos de salud del primer nivel de atención, Perú. *Med Clínica Soc* [Internet]. agosto de 2023 [citado 23 de junio de 2023];7(2):84-94. Disponible en: http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2521-22812023000200084&lng=en&nrm=iso&tlng=es
 11. Chero-García D, Chipana-Torres D, Espinoza-Zanabria E, Espinal-Chipana N, O-Hinostroza CD la, Eusebio-Fernández M, et al. Efectos metabólicos y cambio ponderal por el uso de anticonceptivos hormonales: Una revisión narrativa. *Rev Int Salud Materno Fetal* [Internet]. 29 de junio de 2021 [citado 22 de junio de 2023];6(2). Disponible en: <http://ojs.revistamaternofetal.com/index.php/RISMF/article/view/213>
 12. Pino-Alvarez MJ, Martínez-Flores MI, Navia-Aravena CF, Quiñones-Hidalgo CI, Salas-Martínez VB, Salinas-Valdés JV, et al. Repercusión de la obesidad en la vida sexual de mujeres adultas en américa, 2010-2021. *Rev Matronería Actual* [Internet]. 12 de octubre de 2022 [citado 5 de febrero de 2025];(1):16-16. Disponible en: <https://revistas.uv.cl/index.php/matroneria/article/view/3202>
 13. Disfunciones sexuales en mujeres con obesidad en el Quindío (Colombia), 2016-2019. Estudio de prevalencia. [citado 5 de febrero de 2025]; Disponible en: [https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/UMED/62-3%20\(2021\)/231066999017/](https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/UMED/62-3%20(2021)/231066999017/)
 14. Manrique H. Impacto de la obesidad en la salud reproductiva de la mujer adulta. *Rev Peru Ginecol Obstet* [Internet]. octubre de 2017 [citado 5 de febrero de 2025];63(4):607-14. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S2304-51322017000400014&lng=es&nrm=iso&tlng=es
 15. Serrano Casilla LP. Tiempo de uso e incremento de peso en usuarias de métodos hormonales de progestágenos del C.S. La Esperanza, Tacna 2022. 2023 [citado 14 de mayo de 2024]; Disponible en: <https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/3835>
 16. Orbe Orozco SE. Efecto del estilo de vida y estrés académico en la adherencia del método anticonceptivo hormonal en universitarias millennials. 2021 [citado 24 de agosto de 2023]; Disponible en: <http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9388>
 17. Flores Ormeño ME, Rojas Vera ME. Anticonceptivos hormonales y su relación con

- la obesidad en usuarias continuadoras del centro de salud Mala – Cañete, 2021. [Internet]. [Chincha, Perú]: Universidad Autónoma de Ica; 2022 [citado 26 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/20.500.14441/1907>
18. Silva Delgado ML. Anticonceptivos hormonales como factor asociado a obesidad, Perú 2018. Repos Inst - URP [Internet]. 2021 [citado 10 de mayo de 2024]; Disponible en: <https://repositorio.urp.edu.pe/handle/20.500.14138/3797>
 19. Diaz Chavez VJ, Hernandez Cañeda R del R. Relación entre el uso de métodos hormonales y el peso en usuarias de planificación familiar del Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021. 2022 [citado 10 de mayo de 2024]; Disponible en: <http://repositorio.unheval.edu.pe/handle/20.500.13080/7360>
 20. Ustua Sanchez TT. Relación entre el uso del acetato de medroxiprogesterona y la variación del índice de masa corporal en usuarias de planificación familiar en el centro de salud Pueblo Joven Centenario, Abancay, 2019 [Internet]. [Lima,Perú]: Universidad Alas Peruanas; 2021 [citado 31 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.uap.edu.pe/xmlui/handle/20.500.12990/10013>
 21. Morales Laurente NE. Perfil de forma de vida en usuaria de Planificación familiar con IMC elevado del Centro de Salud David Guerrero Duarte, Concepción 2019. [Internet]. [Perú]: Universidad Nacional de Huancavelica; 2019 [citado 24 de octubre de 2023]. Disponible en: <http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2996>
 22. Velasquez Capristan M del P. Aumento de índice de masa corporal en usuarias de acetato de medroxiprogesterona del servicio de planificación familiar en el Centro de Salud Márquez, enero – diciembre 2018 [Internet]. [Lima,Perú]: Universidad San Martin de Porres; 2019 [citado 31 de diciembre de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/5522>
 23. Organización Mundial de la Salud, Health Education Unit. Life-styles and health. Soc Sci Med [Internet]. 1986 [citado 22 de marzo de 2024];22(2):117-24. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0277953686900602>
 24. Calpa-Pastas AM, Santacruz-Bolaños GA, Álvarez-Bravo M, Zambrano-Guerrero CA, Hernández-Narváez E de L, Matabanchoy-Tulcan SM, et al. PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES: ESTRATEGIAS Y ESCENARIOS. Hacia Promoc Salud [Internet]. julio de 2019 [citado 29 de junio de 2023];24(2):139-55. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0121-75772019000200139&lng=en&nrm=iso&tlng=es
 25. Lasso Jaramillo DA, Ibarra Eraso JC, Bastidas Médicis S, Muñoz Guerrero LD. Estrategias de promoción en hábitos de vida saludable para el bienestar laboral en

- conductores de buses urbanos. 8 de agosto de 2022 [citado 29 de junio de 2023]; Disponible en: <https://repository.ces.edu.co/handle/10946/6138>
26. Montoya LRG, Salazar ARL. Estilo de vida y salud. Educere [Internet]. 2010 [citado 30 de junio de 2023];14(48):13-9. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35616720002>
 27. Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Alcaldía Municipal del Municipio de Yamarangüila Departamento de Intibucá. GUÍA DE ENTORNOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN COMUNIDADES INDÍGENAS LENCAS [Internet]. 2016. Disponible en: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34580/vidasaludable2016-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
 28. Ajzen I. The theory of planned behavior. Organ Behav Hum Decis Process [Internet]. 1 de diciembre de 1991 [citado 7 de febrero de 2025];50(2):179-211. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/074959789190020T>
 29. Margarita CR, Claudia Rocío MG, Moreno AGM. Teoría del comportamiento planificado aplicada a prácticas de compra de alimentos en supermercados. 5 de mayo de 2022 [citado 7 de febrero de 2025]; Disponible en: <https://zenodo.org/records/6521694>
 30. Samaniego-Arias MA, Usiña-Báscones GG. Factores que Influyen en la Intención de Compra de Productos Orgánicos entre los Millennials, utilizando como marco teórico la Teoría del Comportamiento Planificado. Cienc Lat Rev Científica Multidiscip [Internet]. 19 de noviembre de 2024 [citado 7 de febrero de 2025];8(5):8879-97. Disponible en: <https://www.ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/14282>
 31. Gómez Cortés DP. Influencia de los comportamientos de alimentación y actividad física como predictores de la intención de compra de alimentos saludables en jóvenes universitarios de la ciudad de Bogotá para el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio - Modalidad Trabajo de investigación. [Internet]. [Bogotá, Colombia]: Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales; 2024 [citado 7 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://repository.udca.edu.co/handle/11158/6124>
 32. Berra Ruiz E, Muñoz Maldonado SI. El modelo transteórico aplicado al cambio de conductas relacionadas con la reducción del peso corporal. Rev Digit Int Psicol Cienc Soc [Internet]. 2018 [citado 7 de febrero de 2025];4(2):153-70. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8816308>
 33. Bustamante Restrepo C, Franco Soto N, Gómez Quintero M. Promoción de la salud bajo la perspectiva de Nola Pender en una comunidad urbana de Pereira [Internet].

- [Colombia]: Fundación Universitaria del Área Andina; 2023 [citado 6 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://digitk.areandina.edu.co/entities/publication/23e8db12-8b9b-4952-9a33-a1288c71ed95>
34. Aristizábal Hoyos GP, Blanco Borjas DM, Sánchez Ramos A, Ostiguín Meléndez RM. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Una reflexión en torno a su comprensión | Enfermería Universitaria. *Enferm Univ* [Internet]. 2011 [citado 30 de junio de 2023];8(4). Disponible en: <https://revista-enfermeria.unam.mx/ojs/index.php/enfermeriauniversitaria/article/view/248>
 35. Navarro-Rodríguez DC, Guevara-Valtier MC, Paz-Morales M de los Á, Navarro-Rodríguez DC, Guevara-Valtier MC, Paz-Morales M de los Á. Análisis y evaluación del Modelo de Promoción de la Salud. *Temperamentvm* [Internet]. 2023 [citado 6 de febrero de 2025];19. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1699-60112023000100013&lng=es&nrm=iso&tlng=es
 36. Calañas-Continente A. Alimentación saludable basada en la evidencia. *Endocrinol Nutr* [Internet]. 15 de mayo de 2005 [citado 31 de agosto de 2023];52:8-24. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-nutricion-12-articulo-alimentacion-saludable-basada-evidencia-13088200>
 37. Beauman C, Cannon G, Elmadfa I, Glasauer P, Hoffmann I. The Giessen Declaration. *Public Health Nutrition*. 2005;8(6A):783-6.
 38. Macías M AI, Quintero S ML, Camacho R EJ, Sánchez S JM. LA TRIDIMENSIONALIDAD DEL CONCEPTO DE NUTRICIÓN: SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD. *Rev Chil Nutr* [Internet]. diciembre de 2009 [citado 30 de agosto de 2023];36(4):1129-35. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0717-75182009000400010&lng=es&nrm=iso&tlng=es
 39. Izquierdo Hernández A, Armenteros Borrell M, Lancés Cotilla L, Martín González I. Alimentación saludable. *Rev Cuba Enferm* [Internet]. abril de 2004 [citado 12 de octubre de 2023];20(1):1-1. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-03192004000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=es
 40. Alzate Yepes T. Dieta saludable. *Perspect En Nutr Humana* [Internet]. junio de 2019 [citado 31 de agosto de 2023];21(1):9-14. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0124-41082019000100009&lng=en&nrm=iso&tlng=es
 41. Feskens EJM, Bailey R, Bhutta Z, Biesalski HK, Eicher-Miller H, Krämer K, et al. Women's health: optimal nutrition throughout the lifecycle. *Eur J Nutr* [Internet].

- 2022 [citado 6 de febrero de 2025];61(Suppl 1):1-23. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9134728/>
42. Alimentación sana [Internet]. Organización Mundial de la Salud. 2018 [citado 30 de agosto de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>
 43. Organización Mundial de la Salud. Saturated fatty acid and trans-fatty acid intake for adults and children: WHO guideline [Internet]. 2023 [citado 12 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240073630>
 44. Organización Mundial de la Salud. Total fat intake for the prevention of unhealthy weight gain in adults and children: WHO guideline [Internet]. 2023 [citado 12 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240073654>
 45. Organización Mundial de la Salud. Carbohydrate intake for adults and children: WHO guideline [Internet]. 2023. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240073593>
 46. Perea-Caballero AL, López-Navarrete GE, Perea-Martínez A, Reyes-Gómez U, Santiago-Lagunes LM, Ríos-Gallardo PA, et al. Importancia de la Actividad Física. Salud Jalisco [Internet]. 5 de marzo de 2020 [citado 6 de septiembre de 2023];6(2):121-5. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=91852>
 47. Peng B, Ng JYY, Ha AS. Barriers and facilitators to physical activity for young adult women: a systematic review and thematic synthesis of qualitative literature. Int J Behav Nutr Phys Act [Internet]. 27 de febrero de 2023 [citado 6 de febrero de 2025];20(1):23. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12966-023-01411-7>
 48. Actividad física [Internet]. [citado 31 de agosto de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>
 49. Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud [Internet]. 2010 [citado 12 de octubre de 2023]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/oms-recomendaciones-mundiales-sobre-actividad-fisica-para-salud-2010>
 50. World Health Organization, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, United States Agency for International Development. Family Planning - A global handbook for providers [Internet]. 4ta edición. World Health Organization and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.; 2022 [citado 23 de abril de 2023]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9780999203705>
 51. UNFPA Perú. Planificación familiar [Internet]. Fondo de Población de las Naciones

- Unidas. 2022 [citado 23 de abril de 2023]. Disponible en: <https://www.unfpa.org/es/planificaci%C3%B3n-familiar>
52. UNFPA Perú. Planificación familiar, por un mundo con iguales oportunidades [Internet]. UNFPA Perú. 2021 [citado 23 de abril de 2023]. Disponible en: <https://peru.unfpa.org/es/news/planificaci%C3%B3n-familiar-por-un-mundo-con-iguales-oportunidades>
53. Ministerio de Salud. Norma técnica de salud de planificación familiar. 2017.
54. Iglesias Moya J. Principales métodos anticonceptivos, revisión de la matrona [Internet]. Revista Electrónica de Portales Medicos.com. 2016 [citado 3 de julio de 2022]. Disponible en: <https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/principales-metodos-anticonceptivos/>
55. Somogyi L, Mora E. Métodos anticonceptivos: Entonces y ahora. Rev Obstet Ginecol Venezuela [Internet]. junio de 2011 [citado 2 de julio de 2022];71(2):118-23. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0048-77322011000200006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
56. Aditiya Kusumaningtyas Z, Tamtomo D, Bhisma M. Meta-Analysis the Effect of Hormonal Contraception on the Weight Gain and Hypertension in Women of Reproductive Age | Journal of Maternal and Child Health. Journal of Maternal and Child Health [Internet]. 2022 [citado 6 de febrero de 2025];7(6):699-710. Disponible en: <https://thejmch.com/index.php/thejmch/article/view/868>
57. Endalifer ML, Alen GD, Addisu A, Linger B. The association between combined oral contraceptive use and overweight/obesity: a secondary data analysis of the 2016 Ethiopia Demographic and Health Survey. 1 de diciembre de 2020 [citado 6 de febrero de 2025]; Disponible en: <https://bmjopen.bmj.com/content/10/12/e039229>
58. Vigil P, Meléndez J, Petkovic G, Del Río JP. The importance of estradiol for body weight regulation in women. Front Endocrinol [Internet]. 7 de noviembre de 2022 [citado 6 de febrero de 2025];13:951186. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9677105/>
59. Lopez LM, Ramesh S, Chen M, Edelman A, Otterness C, Trussell J, et al. Progestin-only contraceptives: effects on weight. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 28 de agosto de 2016 [citado 7 de febrero de 2024];2016(8):CD008815. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5034734/>
60. Quispe Mamani JR. Variación del peso e índice de masa corporal de mujeres en edad fértil que utilizan anticonceptivos hormonales en 6 establecimientos de primer nivel de la Red Senkata del Municipio de El Alto, gestión 2017 – 2018 [Internet] [Thesis]. 2020 [citado 14 de mayo de 2024]. Disponible en: <http://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/24824>

61. Cordova Naupay CN, Quintana Cañari EM. Efectos del uso del Acetato De Medroxiprogesterona en el Estado Nutricional de Usuaris Atendidas del Hospital Félix Mayorca Soto, 2019 [Internet] [Tesis Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia]. [Cerro de Pasco, Perú]: Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión; 2022 [citado 21 de mayo de 2024]. Disponible en: <http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2867>
62. Cruzado Vásquez CM del R. Acetato de medroxiprogesterona y su relación con la obesidad en usuarias continuadoras del Centro Materno Infantil Santa Luzmila II. Enero-diciembre 2019 [Internet] [Tesis Para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia]. [Lima,Perú]: Universidad Privada del Norte; 2021. Disponible en: <https://hdl.handle.net/11537/26055>
63. Beksinska M, Wong R, Smit J. Male and female condoms: Their key role in pregnancy and STI/HIV prevention. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol [Internet]. 1 de julio de 2020 [citado 4 de mayo de 2023];66:55-67. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521693419301774>
64. Ramos Pascual NT. Variación del peso e índice de masa corporal en usuarias nuevas adultas de acetato de medroxiprogesterona del servicio de planificación familiar en el Instituto Nacional Materno Perinatal, 2015 - 2016 [Internet]. [Lima,Perú]: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2017 [citado 14 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/6651>
65. Ramos Quispe MB. Efectos del implante subdermico de etonogestrel en usuarias del consultorio de planificación familiar del Instituto Nacional Materno Perinatal febrero 2014 enero 2015 [Internet]. [Lima,Perú]: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2015 [citado 21 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/4317>
66. Overweight and Obesity - PAHO/WHO | Pan American Health Organization [Internet]. Pan American Health Organization / World Health Organization. [citado 5 de enero de 2025]. Disponible en: <https://www.paho.org/en/enlace/overweight-and-obesity>
67. Organización Mundial de la Salud. Salud sexual [Internet]. [citado 3 de julio de 2022]. Disponible en: <https://www.who.int/es/health-topics/sexual-health>
68. Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD). El Cairo; 1994.
69. Basiotis PP, Carlson A, Gerrior SA, Juan WY, Lino M, editores. The Healthy Eating Index: 1999-2000. 2002. 34 p. (CNPP-12).
70. Romero-Berrocal Y, López-Ponce CN. Índice de alimentación saludable y exceso

- de peso, en jóvenes de 14 a 17 años del distrito de Chilca - 2020 [Internet]. [Huancayo, Perú]: Universidad Peruana Los Andes; 2021. Disponible en: <https://repositorio.upla.edu.pe/handle/20.500.12848/3117#:~:text=Se%20leg%C3%B3%20a%20la%20conclusi%C3%B3n,educaci%C3%B3n%20nutricional%20a%20la%20poblaci%C3%B3n>.
71. Craig CL, Marshall AL, Sjöström M, Bauman AE, Booth ML, Ainsworth BE, et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. *Med Sci Sports Exerc.* agosto de 2003;35(8):1381-95.
 72. Lecca Marreros IA, Cueva Reyes E. Actividad física y riesgo cardiovascular en estudiantes de la Escuela Profesional de Arquitectura de una universidad privada de Lima-Este, 2018 [Internet]. Universidad Peruana Unión; 2019 [citado 4 de febrero de 2025]. Disponible en: <http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/1746>
 73. Mantilla Toloza SC, Gómez-Conesa A. El Cuestionario Internacional de Actividad Física. Un instrumento adecuado en el seguimiento de la actividad física poblacional. *Rev Iberoam Fisioter Kinesiol* [Internet]. 1 de enero de 2007 [citado 29 de septiembre de 2023];10(1):48-52. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-iberoamericana-fisioterapia-kinesiologia-176-articulo-el-cuestionario-internacional-actividad-fisica--13107139>
 74. Serrano Casilla LP. Tiempo de uso e incremento de peso en usuarias de métodos hormonales de progestágenos del C.S. La Esperanza, Tacna 2022 [Internet]. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann; 2023 [citado 5 de enero de 2025]. Disponible en: <https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/3835>

ANEXOS

Anexo 1

Consentimiento informado

La invito a participar del estudio titulado “Estilos de vida en usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024” realizado por la estudiante Mariana Alessandra Arredondo Aramburú, perteneciente a la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para obtener el título de Licenciada en Obstetricia. El propósito de la presente investigación es determinar los estilos de vida en las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso.

Antes de decidir si desea participar o no en el estudio, se le brindará información necesaria y se responderán las dudas que tenga con respecto a la investigación para que pueda tomar una decisión informada.

Procedimientos

Si usted acepta participar se le entregará un cuestionario para ser llenado, se le pedirá datos generales y datos de antecedentes reproductivos. Asimismo, se le solicitará el llenado de los cuestionarios “Índice de alimentación saludable” y “Cuestionario Internacional de actividad física IPAQ”, el cual podrá marcar con una “X” la alternativa que usted crea conveniente, su participación será de 20 minutos aproximadamente.

Beneficios:

Este estudio tiene como beneficio el poder aportar al conocimiento científico sobre los estilos de vida en las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales. Asimismo, beneficia a los participantes de manera indirecta porque permitiría reflejar la situación de salud de las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales y con ello contribuir a la elaboración de estrategias por parte de las autoridades de salud para futuras intervenciones en caso sea necesario.

Riesgos:

No existen riesgos al participar en la investigación debido a que es del tipo observacional, por lo que no se expone a la participante a ningún

procedimiento que pueda afectar su integridad.

Confidencialidad

Toda la información recolectada será confidencial, por lo que su identidad será manejada con códigos y sólo la investigadora tendrá acceso a la información de identificación de los participantes, la cual no será publicada.

Incentivos:

La participación en esta investigación no implica el pago económico por parte de usted ni por parte del investigador.

Derechos del participante:

Si usted decide participar en el estudio, podrá retirarse en cualquier momento si así lo desea sin perjuicio alguno. Si tiene dudas adicionales acerca del estudio se puede comunicar con la investigadora Mariana Alessandra Arredondo al celular 989138475 o al correo electrónico: mariana.arredondo@unmsm.edu.pe.

Si desea participar en este estudio, complete su información en esta hoja de consentimiento.

Declaración de la participante:

He leído la información proporcionada y ha sido explicada correctamente. He tenido la oportunidad de preguntar sobre el estudio y contestaron satisfactoriamente todas mis dudas. Acepto voluntariamente mi participación en este estudio y comprendo que puedo retirarme en cualquier momento. Entiendo que los resultados de la investigación serán utilizados con fines académicos y profesionales.

Apellidos y nombre del participante

Firma

Fecha

Anexo 2

Estilos de vida en usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024

I. DATOS GENERALES

1. ¿Entre qué rango de edad te encuentras?
 - a. 18 - 29 años
 - b. 30 - 49 años
 - c. Mayor a 49 años
2. ¿Cuál es tu estado civil actual?
 - a. Soltera
 - b. Casada
 - c. Viuda
 - d. Divorciada
3. ¿Cuál es tu ocupación actual?
 - a. Trabajador dependiente
 - b. Trabajador independiente
 - c. No trabaja actualmente
 - d. Estudiante
4. ¿Qué nivel educativo has alcanzado?
 - a. Sin estudios
 - b. Inicial
 - c. Primaria incompleta
 - d. Primaria completa
 - e. Secundaria incompleta
 - f. Secundaria completa
 - g. Superior incompleta
 - h. Superior completa
5. ¿Qué religión profesas?
 - a. Católica
 - b. Evangélica
 - c. Adventista

- d. Testigo de Jehová
 - e. Agnosticismo
 - f. Ateísmo
 - g. Otro
6. ¿Cuál es tu lengua materna?
- a. Castellano
 - b. Quechua
 - c. Aimara
 - d. Otra lengua aborigen
 - e. Otra lengua extranjera
7. Nacionalidad
- a. Peruana
 - b. Venezolana
 - c. Otra

II. DATOS REPRODUCTIVOS

1. ¿A qué edad fue tu primera menstruación?
- a. 8-10 años
 - b. 11-13 años
 - c. 14-16 años
 - d. Más de 17 años
2. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual?
- a. 11-13 años
 - b. 14-16 años
 - c. 17 - 19 años
 - d. 20 - 25 años
 - e. Más de 25 años
3. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido?
- a. 1 - 2
 - b. 3 - 4
 - c. 5 - 10
 - d. Más de 10
4. ¿Cuántos embarazos has tenido?
- a. No he tenido ningún embarazo

- b. 1 - 2
- c. 3 - 4
- d. Más de 5 embarazos

IV. USO DE MÉTODO ANTICONCEPTIVO

1. ¿Qué método anticonceptivo utilizas actualmente?
 - a. Anticonceptivos orales combinados
 - b. Inyectable/Ampolla mensual
 - c. Inyectable/Ampolla trimestral
 - d. Implante
2. ¿Hace cuánto tiempo utilizas tu método anticonceptivo actual?
(Verificar en tu tarjeta/cartilla de control en planificación familiar)
 - a. 1 año
 - b. 2 años
 - c. 3 años
 - d. Más de 5 años
 - e. _____ Meses
3. ¿Has presentado alguno de los siguientes síntomas durante el uso de tu método anticonceptivo hormonal?
 - a. Cefalea
 - b. Cambios en el apetito (incremento)
 - c. Ciclos menstruales irregulares.
 - d. Amenorrea
 - e. Mastalgia
 - f. Náuseas
 - g. Acné
 - h. Alteraciones en el peso
 - i. Dolor abdominal
 - j. Otro
 - k. Ningún síntoma

Anexo 3

Cuestionario de Índice de alimentación saludable

1. ¿Cuántas veces consume cereales y derivados? (pan, fideos, avena, entre otros)
 - a. Consumo diario
 - b. 3 o más veces a la semana, pero no diario
 - c. 1 o 2 veces a la semana
 - d. Menos de una vez a la semana
 - e. Nunca o casi nunca
2. ¿Cuántas veces consume verduras y hortalizas?
 - a. Consumo diario
 - b. 3 o más veces a la semana, pero no diario
 - c. 1 o 2 veces a la semana
 - d. Menos de una vez a la semana
 - e. Nunca o casi nunca
3. ¿Cuántas veces consume frutas?
 - a. Consumo diario
 - b. 3 o más veces a la semana, pero no diario
 - c. 1 o 2 veces a la semana
 - d. Menos de una vez a la semana
 - e. Nunca o casi nunca
4. ¿Cuántas veces consume leche, derivados? (leche, yogurt, queso, entre otros)
 - a. Consumo diario
 - b. 3 o más veces a la semana, pero no diario
 - c. 1 o 2 veces a la semana
 - d. Menos de una vez a la semana
 - e. Nunca o casi nunca
5. ¿Cuántas veces consume carnes y huevos?
 - a. Consumo diario
 - b. 3 o más veces a la semana, pero no diario
 - c. 1 o 2 veces a la semana
 - d. Menos de una vez a la semana

- e. Nunca o casi nunca
- 6. ¿Cuántas veces consume leguminosas? (como garbanzo, arveja, entre otros)
 - a. Consumo diario
 - b. 3 o más veces a la semana, pero no diario
 - c. 1 o 2 veces a la semana
 - d. Menos de una vez a la semana
 - e. Nunca o casi nunca
- 7. ¿Cuántas veces consume embutidos y jamones?
 - a. Consumo diario
 - b. 3 o más veces a la semana, pero no diario
 - c. 1 o 2 veces a la semana
 - d. Menos de una vez a la semana
 - e. Nunca o casi nunca
- 8. ¿Cuántas veces consume dulces y bebidas azucaradas? (como galletas, caramelos y golosinas dulces: fruna, chupetines, entre otros y gaseosas, jugos carbonatados, “néctares”)
 - a. Consumo diario
 - b. 3 o más veces a la semana, pero no diario
 - c. 1 o 2 veces a la semana
 - d. Menos de una vez a la semana
 - e. Nunca o casi nunca
- 9. ¿Cuántas veces consume bebidas alcohólicas?
 - a. Consumo diario
 - b. 3 o más veces a la semana, pero no diario
 - c. 1 o 2 veces a la semana
 - d. Menos de una vez a la semana
 - e. Nunca o casi nunca

ANEXO 4

Cuestionario de actividad física (IPAQ)

Piense acerca de todas aquellas actividades vigorosas que usted realizó en los últimos 7 días. Actividades vigorosas son aquellas que requieren un esfuerzo físico fuerte y le hacen respirar mucho más fuerte que lo normal. Piense solamente en esas actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos continuos.

1. Durante la última semana, ¿Cuántos días realizó usted actividades físicas vigorosas como levantar objetos pesados, correr, aeróbicos o pedalear rápido en bicicleta? (Si no realiza estas actividades deje en blanco y pase a la pregunta 3)

2. ¿Cuánto tiempo en total usualmente le tomo realizar actividades físicas vigorosas en uno de esos días que las realizó? En minutos u horas

Piense acerca de todas aquellas actividades moderadas que usted realizó en los últimos 7 días. Actividades moderadas son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado y le hacen respirar mucho algo fuerte que lo normal. Piense solamente en esas actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos continuos.

3. Durante la última semana, ¿Cuántos días realizó usted actividades físicas moderadas como levantar objetos livianos, pedalear en bicicleta a paso regular, o jugar dobles en tenis? No incluya caminatas. (Si no realiza estas actividades deje en blanco y pase a la pregunta 5)

4. Usualmente ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo actividades físicas moderadas?

Piense acerca del tiempo que usted dedicó a caminar en los últimos 7 días. Esto incluye trabajo en la casa, caminatas para ir de un sitio a otro, o cualquier otra caminata que usted hizo únicamente por recreación, ejercicio o placer.

5. Durante la última semana ¿Cuántos días caminó usted por al menos 10 minutos continuos? (Si no realiza estas actividades deje en blanco y pase a la pregunta 7)

6. Usualmente ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días caminando?

La última pregunta se refiere al tiempo que usted permaneció sentado(a) en los últimos 7 días. Incluya el tiempo sentado(a) en el trabajo, la casa, estudiando, y en su tiempo libre. Esto puede incluir tiempo sentado(a) en un escritorio, leyendo o permaneciendo sentado(a) o acostado(a) mirando TV.

7. Durante la última semana. ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a) en un día?

ANEXO 5
Ficha de registro

I. Características sociodemográficas de la población:

Historia clínica: _____ Edad: _____ Procedencia: _____

Grado de instrucción: _____ Estado civil: _____

II. Datos de la variación del peso e índice de masa corporal

Talla	
Peso al inicio de aplicación del método	
IMC al inicio de aplicación del método	
Peso al término de aplicación por un año del método	
IMC al término de aplicación por un año del método	

ANEXO 6
Criterios de puntuación del Índice de alimentación saludable

Grupo de alimento		Criterios para puntuación máxima de 10	Criterios para puntuación máxima de 8	Criterios para puntuación máxima de 6	Criterios para puntuación máxima de 4	Criterios para puntuación máxima de 0
Consumo diario	Cereales y derivados	Consumo diario	3 veces o más a la semana	1 o 2 veces a la semana	Menos de 1 vez a la semana	Nunca o casi nunca
	Verduras y hortalizas					
	Frutas					
	Leche y derivados					
Consumo semanal	Carnes	1 o 2 veces a la semana	3 veces o más a la semana	Menos de 1 vez a la semana	Consumo diario	Nunca o casi nunca
	Leguminosas					
Consumo ocasional	Embutidos y jamones	Nunca o casi nunca	Menos de 1 vez a la semana	1 o 2 veces a la semana	3 veces o más a la semana	Consumo diario
	Dulces					
	Bebidas azucaradas					

Alimentación saludable: 80 - 100 puntos

Necesita cambios: 50 - 79 puntos

Alimentación poco saludable: Menos de 50 puntos

ANEXO 7
Matriz de consistencia

Título: Estilos de vida en usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024.

Problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Metodología
¿Cómo son los estilos de vida en las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales que han presentado un incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo?	Objetivo general: Determinar los estilos de vida en las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales que han presentado incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024. Objetivos específicos: • Identificar a las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales que han experimentado un incremento de peso, a partir de los tres meses de uso. • Clasificar a las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso según el índice de masa corporal, a partir de los 3 meses de uso.	Debido a la naturaleza descriptiva del estudio no se considerará una hipótesis en el estudio.	Variable de estudio: Estilos de vida Variable interviniente: Peso durante el periodo de uso del método anticonceptivo hormonal	Tipo de investigación: Estudio cuantitativo observacional. Diseño: Descriptivo corte transversal, y prospectivo. Población: Mujeres usuarias de métodos anticonceptivos hormonales que presentan incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, durante los meses de agosto y septiembre de 2024. Muestra: Censal Muestreo: No probabilístico Técnica: Encuestas y documental

	• Describir los estilos de vida sobre la alimentación en las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso. • Caracterizar los estilos de vida sobre la actividad física en las usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso.			Instrumentos: • Cuestionario de Índice de alimentación saludable • Cuestionario de actividad física (IPAQ) • Hoja de registro Análisis de datos: • Programa Excel
--	---	--	--	---

Anexo 8

Resolución decanal



Firmado digitalmente por PODESTA
GAVILANO Luis Enrique FAU
20140802202 noB
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.07.2024 12:18:47 -05:00

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú. Decana de América
FACULTAD DE MEDICINA
DECANATO

Lima, 05 de Julio del 2024

RESOLUCIÓN DECANAL N° 003600-2024-D-FM/UNMSM

Visto el expediente digital N° F01B2-20240000159, de fecha 02 de julio de 2024 de la Facultad de Medicina, sobre aprobación de Proyecto de tesis.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Decanal N° 002373-2023-D-FM/UNMSM de fecha 19 de junio de 2023 ratificada con Resolución Rectoral N° 003396-2024 de fecha 04 de marzo del 2024 se aprueba el Reglamento para la Elaboración de Tesis para optar el Título Profesional en las Escuelas Profesionales de la Facultad de Medicina, que en su Capítulo V. DE LA PLANIFICACION, Art. 8: establece que: "La tesis (T) podrá ser individual o grupal (máximo tres), compartiéndose las responsabilidades de la elaboración." así mismo, en su Capítulo VI: Del Asesoramiento aprobación e inscripción del proyecto de tesis: Art. 23 establece que: "Con la aprobación del proyecto por parte del Comité de Investigación correspondiente y, de un Comité de Ética en Investigación, la Dirección de la EP solicitará al Vicedecanato Académico la Resolución Decanal de la aprobación del proyecto, y el tesisista podrá iniciar la ejecución de su proyecto de tesis;

Que, mediante Oficio N°000193-2024-EPO-FM/UNMSM, la Directora de la Escuela Profesional de Obstetricia, informa que los Proyectos de Tesis que figura en la propuesta cuenta con opinión favorable del Comité de Investigación de la citada Escuela para su ejecución; y,

Estando a lo establecido por el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 30220;

SE RESUELVE:

1° Aprobar los Proyectos de Tesis, según detalle:

N°	AUTORES	CODIGO	ASESOR	TITULO
1.	Katia Candy Arias Espinoza	18010374	Dra. Emma Felicia Salazar Salvatierra Código N° 06346E	Características epidemiológicas y clínicas de gestantes en la atención prenatal mediante Telemonitoreo durante la pandemia COVID 19, Instituto Nacional Materno Perinatal, 2021
2	Mariana Alessandra Arredondo Aramburu	20010256	Dra. Emma Felicia Salazar Salvatierra Código N° 06346E	Estilos de vida en usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024
3	Cabezas Flores Ericka Janeth	17010358	Mg. Milagros Elizabeth Gonzales Falcón Código N° 0A4185	Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres adolescentes según la Encuesta Demográfica de Salud Familiar 2022



Firmado digitalmente por
FERNANDEZ GIUSTI VDA DE
PELLA Alicia Jesus FAU
20140802202 noB
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.07.2024 09:38:27 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://spsgd.unmsm.edu.pe/verifica/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: OVLVUTI



Anexo 9

Acta de aprobación del Comité de Ética



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCO
(Universidad del Perú DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE MEDICINA
INSTITUTO DE ÉTICA EN SALUD
COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN



*"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y la
Comemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"*

ACTA DE EVALUACIÓN ÉTICA DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

CODIGO DE ESTUDIO N°: 0186-2024

En Lima, a los veintitrés días del mes de julio, en Sesión del COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, previa evaluación del Proyecto de Tesis de Pregrado titulado: "Estilos de vida en usuarias de métodos anticonceptivos hormonales con incremento de peso en el Centro Materno Infantil Surquillo, 2024" presentada por **Mariana Alessandra Arredondo Aramburu** con código 20010256, de la escuela profesional de obstetricia, para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

ACUERDA:

Dar por **APROBADO** dicho Proyecto, considerando que se ha cumplido satisfactoriamente con las recomendaciones en aspectos Científicos Técnicos y Éticos para la investigación en seres humanos.

"El presente documento tiene vigencia a partir de la fecha y expira el 22 de julio de 2025"

Lima, 23 de julio de 2024



JUAN CARLOS OCAMPO ZEGARRA
PRESIDENTE DEL C.E.I. / F.M. / U.N.M.S.M.
FACULTAD DE MEDICINA SAN FERNANDO
CÓDIGO DOCENTE: DA3079
CMP: 043040 - RNE: 028980 - RNSE: S00415

Dr. Juan Carlos Ocampo Zegarrra
Presidente del CEI/FM/UNMSM

Anexo 10

Acta de autorización de ejecución de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

	PERÚ	Ministerio de Salud	Ministerio de Investigaciones y Promoción en Salud	Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro
---	-------------	----------------------------	---	---

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

CONSTANCIA N° 57

**AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ACTA N°10 -2024-COM.INV-DIRIS-LC
EXPEDIENTE N.º 202449348**

La que suscribe, Directora General de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, da Constancia que:

MARIANA ALESSANDRA ARREDONDO ARAMBURU

Autora del Proyecto de Investigación: "ESTILOS DE VIDA EN USUARIAS DE METODOS ANTICONCEPTIVOS HORMONALES CON INCREMENTO DE PESO EN EL CENTRO MATERNO INFANTIL SURQUILLO 2024" ha cumplido con los requisitos exigidos por la Unidad Funcional de Docencia e Investigación y el Comité de Investigación de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro, dando por **APROBADO**, la Autorización para la Ejecución del Proyecto de Investigación, teniendo una vigencia de:

FECHA DE INICIO : 25 de Setiembre del 2024.
FECHA DE TÉRMINO : 31 de Marzo del 2025.

Asimismo, se le informa que su responsabilidad culmina con la presentación del informe Final, la publicación y socialización de resultados con las Oficinas, Estrategias y Establecimientos de Salud de interés de la jurisdicción, en bien de la Salud Pública del País.

Esperando el cumplimiento de todo lo antes mencionado, quedo de usted.

Lima, 26 de Septiembre del 2024.

Atentamente,


M.C. DEYLA F. DAVILA VIGIL
Directora General
C.M.P. 51670


DFDV/RLMC